

ÍNDICE. MÓDULO 1.

Inicio: **Mapa IBIS.** Éticas en la práctica clínica. (Pautas contractuales, Límites de la relación, Competencia, Confidencialidad, etc.)

1. Ariel, A. "Moral y Ética. Una poética del estilo"
2. Lewkowicz, I. "Particular, Universal, Singular. (Cap. IV)".
3. Michel Fariña "El doble movimiento de la ética contemporánea".
4. Michel Fariña "Tatuajes en la escuela primaria".
5. Sófocles "Antígona".
6. Michel Fariña "El interés ético de la tragedia (Cap. V)".
7. Gutiérrez, C. "Antígona y el rito funerario. (Cap. VII)".

MÓDULO 2.

1. Salomone, G. Z. "Consideraciones sobre la ética profesional."
2. Salomone, G. Z. "Responsabilidad profesional".
3. Calo. "La interacción del profesional con los códigos".
4. Dominguez, M. E. La singularidad en los códigos de ética".
5. Ley de Salud Mental N.º 26657.
6. Lewkowicz, I. "Singularidades codificadas".
7. Freud, S. "Puntualizaciones sobre el amor de transferencia".
8. Salomone, G. Z. "El principio de neutralidad y la regla de abstinencia".
9. Laso et al. "Un método peligroso".
10. Ormart, E. "Factores a ponderar en las relaciones amorosas entre terapeutas y ex pacientes".
11. Gutiérrez, Salomone. "El abuso contra los niños. Responsabilidad, legislación y principios éticos"

MÓDULO 3.

1. American Psychological Association. "Código de Ética. (2010)".
2. Asociación de psicólogos de Buenos Aires. "Código de ética".
3. Laso. "Las coordenadas de la obediencia".
4. Michel Fariña, J.J. "De la eugenesia a los crímenes nazis".
5. Ormart et al. "Problemas éticos en la experimentación psicológica".
6. Salomone, G. Z. y Michel Fariña, J. J. "El experimento de Stanley Milgram: Cuestiones éticas y metodológicas".
7. FePRA. "Código de Ética de la República Argentina"

MÓDULO 4.

1. Arendt, H. "Responsabilidad personal bajo una dictadura".
2. Calligaris, C. "La seducción totalitaria".
3. Gutiérrez, C. "Eichmann y la responsabilidad".
4. Gutiérrez, C; Lewkowicz, I. "Memoria, Víctima y Sujeto".
5. Lewkowicz, I. "Catástrofe. Experiencia de una nominación".
6. Michel Fariña, J. y Gutiérrez, C. "Veinte años son nada".
7. Ulloa, F. "Ética del analista ante lo siniestro".
8. Viñar, M. "La transmisión del patrimonio mortífero: premisas éticas para la rehabilitación de afectados".
9. Los cuatro casos de la serie "PSI" ("In treatment", "En Terapia").
 - Caso Renato. Identidad de Género y Particularismo.
 - Caso Laura. Amor de Transferencia y Abstinencia.
 - Caso Paula. Muerte Digna - "La vida en mis manos".
 - Caso Alberto. Pornografía Infantil - "¿Es la fantasía un delito?"

Mapa **IBIS**. (Pautas contractuales, Límites de la relación, Competencia, Confidencialidad, etc.)

ÁREA: Pautas Contractuales (Encuadre)

- **Capítulo: Consentimiento Informado.** Preguntas: ¿Está en condiciones de consentir? ¿Alcances del tratamiento? ¿Documentado? ¿Virtualidad/firma digital? ¿Información sobre riesgos y beneficios?
- **Capítulo: Honorarios.** Preguntas: Criterios de modificación, participación por derivación, trueque, honorarios diferenciales, obras sociales/prepagas, bonificaciones, manejo de deudas.
- **Capítulo: Finalización del Tratamiento.** Preguntas: Criterios de alta, abandono de tratamiento, derivación, manejo de la terminación, continuidad de cuidados.
- **Capítulo: Asistencia y Puntualidad.** Preguntas: Política de inasistencias, cancelaciones, tardanzas, flexibilidad del encuadre.

ÁREA: Límites de la relación

- **Capítulo: Involucración Sexual.** Preguntas: ¿Límites de la atracción? ¿Relaciones con ex-pacientes? ¿Explotación sexual? ¿Manejo de la transferencia/contratransferencia.
- **Capítulo: Relaciones Múltiples / Dualidad de roles.** Preguntas: ¿Existe conflicto de intereses? ¿Relaciones sociales, comerciales o laborales con el paciente? ¿Tratamiento a familiares o allegados.
- **Capítulo: Mal uso del trabajo del profesional.** Preguntas: ¿Uso de información para beneficio propio? ¿Manipulación del paciente? ¿Dependencia inducida.
- **Capítulo: Regalos y Obsequios.** Preguntas: ¿Aceptación de regalos? ¿Valor simbólico vs. económico? ¿Impacto en la relación terapéutica.

ÁREA: Competencia

- **Capítulo: Capacitación.** Preguntas: ¿Área de competencia? ¿Necesidad de formación continua? ¿Límites de la propia práctica? ¿Cuándo derivar.
- **Capítulo: Clarificación de Roles.** Preguntas: ¿Rol forense vs. clínico? ¿Evaluador vs. tratante? ¿Peritaje? ¿Conflicto de roles en instituciones.
- **Capítulo: Salud del Profesional.** Preguntas: ¿Cómo afecta la salud física/mental a la práctica? ¿Cuándo suspender la práctica? ¿Autocuidado y prevención del burnout.

ÁREA: Confidencialidad

- **Capítulo: Secreto Profesional.** Preguntas: ¿Alcances? ¿Historia clínica? ¿Resguardo de datos? ¿Conservación de registros.
- **Capítulo: Ruptura de la Confidencialidad.** Preguntas: ¿Riesgo cierto de daño a terceros? ¿Maltrato infantil/anciano/vulnerable? ¿Orden judicial? ¿Enfermedades de declaración obligatoria.
- **Capítulo: Interconsultas y Trabajo en Equipo.** Preguntas: ¿Cómo compartir información? ¿Consentimiento para compartir? ¿Trabajo en instituciones vs. práctica privada.

ÁREA: Supervisión

- **Capítulo: Deber de Supervisión e Interconsulta.** Preguntas: ¿Cuándo es necesaria? ¿Supervisión clínica vs. ética? ¿Casos complejos? ¿Obligación deontológica.
- **Capítulo: Confidencialidad en Supervisión.** Preguntas: ¿Cómo anonimizar casos? ¿Responsabilidad del supervisor? ¿Límites de la supervisión.

ÁREA: Nuevas tecnologías

- **Capítulo: Telepsicología / Atención Virtual.** Preguntas: ¿Plataformas seguras? ¿Consentimiento específico? ¿Contingencias técnicas? ¿Jurisdicción y marco legal.
- **Capítulo: Redes Sociales y Búsquedas.** Preguntas: ¿Buscar pacientes en redes? ¿Aceptar solicitudes de amistad? ¿Publicación de casos (con/sin consentimiento)?

ÁREA: Medicación

- **Capítulo: Prescripción y Seguimiento.** Preguntas: ¿Uso off-label? ¿Efectos adversos? ¿Adherencia al tratamiento? ¿Interconsultas psiquiátricas.
- **Capítulo: Relación con Laboratorios.** Preguntas: ¿Regalos de laboratorios? ¿Conflictos de interés en prescripción? ¿Patrocinios de eventos.

ÁREA: Derechos humanos

- **Capítulo: Derechos de las Personas con Padecimiento Mental.** Preguntas: ¿Internación involuntaria? ¿Criterio de peligrosidad? ¿Derecho a

la información? ¿Consentimiento? ¿Capacidad jurídica? ¿Modelos de atención comunitaria.

- **Capítulo: Investigación Clínica.** Preguntas: ¿Comités de ética? ¿Consentimiento en investigación? ¿Vulnerabilidad de los sujetos? ¿Riesgos y beneficios? ¿Conflicto de intereses del investigador.

Desglose de las referencias de los autores mencionados en la clase, para luego sistematizar los conceptos centrales.

Distinción de Autores y Referencias Teóricas

Autor / Refe.	Aporte central mencionado en la clase
Konrad Lorenz	Etólogo que definió el instinto como una pauta de comportamiento innata, no aprendida e inscrita genéticamente.
Sigmund Freud	Mención a los errores de sus primeras traducciones, donde se confundió "instinto" (animal) con "pulsión" (humana).
Jacques Lacan	El ser humano como "habitante del lenguaje". Conceptos de acto (ruptura) y la diferencia clínica entre enunciado y enunciación .
Alejandro Ariel	Autor que compara la relación entre Estética y Estilo con la relación entre Moral y Ética.
J.J. Michel Fariña	Titular histórico de la materia. Aporta la idea de la ética como un "horizonte" y el análisis del acto ético en la tragedia de Antígona.
Élisabeth Roudinesco	Biógrafa de Lacan. Citada para ilustrar cómo Lacan asumía la responsabilidad clínica al aceptar pacientes graves que otros rechazaban por seguir protocolos.
Émile Benveniste	Lingüista (aludido indirectamente en el debate de las abejas) que diferencia la comunicación animal (señales) del lenguaje humano.

Ejes Temáticos para tus Apuntes

1. La Condición Humana: Ética vs. Instinto

El punto de partida de la materia es que **la ética atañe exclusivamente a los seres hablantes**.

- Los animales (como las hormigas o abejas) se rigen por el **instinto**, un código genético y cerrado que no requiere elecciones.

- Los humanos no poseemos instinto; somos habitantes del campo del lenguaje. Al no estar condicionados genéticamente para actuar, nuestras acciones siempre suponen una **elección** y, en consecuencia, una **responsabilidad**.

2. Ética y Moral: Diferencias Fundamentales

Aunque etimológicamente comparten origen (la palabra griega *ethos* y la latina *mos* significan "costumbre"), la cátedra las separa tajantemente.

- **La Moral:** Es un sistema de valores compartidos por un grupo o época que orienta las acciones (lo que está "bien" o "mal"). Funciona generando un **universo**, es decir, la ilusión de que ese sistema es completo y tiene respuesta para cualquier situación de la vida. Existen múltiples morales (conservadoras, progresistas, etc.) y suelen chocar entre sí.
- **La Ética:** Implica poner la moral en interrogación. Aparece allí donde el sistema moral agota sus respuestas y se produce una pregunta.

3. Las Categorías Lógicas: Lo Particular y lo Universal-Singular

La materia utiliza la lógica para ordenar estos conceptos en dos grandes ejes:

- **El eje de lo Particular:** Abarca todo lo que agrupa y permite la vida en comunidad. Incluye los sistemas morales, las leyes del Estado y los Códigos de Ética profesionales (Deontología). Son acuerdos históricos y cambiantes.
- **El eje de lo Universal-Singular:** Es el campo propiamente ético. Se relaciona con el sujeto en situación y con la emergencia de algo nuevo que quiebra el orden particular.

4. La Analogía del Arte (Estética vs. Estilo)

Siguiendo a Alejandro Ariel, se traza un paralelismo muy útil para los exámenes:

- **Estética (El Canon):** Equivale a la **Moral**. Son las reglas compartidas de lo que se considera "buen arte" (ej. el canon literario propuesto por teóricas como Beatriz Sarlo).
- **Estilo (El Acto):** Equivale a la **Ética**. Es la marca singular de un autor (ej. James Joyce) que rompe con el canon establecido y crea algo totalmente nuevo.

5. El Acto Ético

El acto ético no es una simple "acción", sino un movimiento que produce un corte o ruptura con las marcas previas (lo moral).

- Se produce en **soledad**: No hay garantías ni "Otro" que asegure de antemano que la decisión es correcta.
- Instituye un **saber suplementario**: El acto ético amplía el horizonte previo y funda una nueva verdad que antes no existía (ejemplo clásico de la cátedra: Antígona eligiendo enterrar a su hermano desafiando la ley de la polis).

6. Ética Profesional, Protocolos y Responsabilidad

La clase aterriza estos conceptos filosóficos en la práctica del psicólogo.

- **Deontología no es Ética**: Conocer los códigos del Colegio de Psicólogos es obligatorio (ámbito Particular), pero aplicarlos ciegamente no es un acto ético. La ética exige leer cada caso en su propia **situación**.
- **El riesgo de la obediencia**: Escudarse ciegamente en un protocolo (como los algoritmos de ChatGPT ante el riesgo suicida, o el miedo a la mala praxis médica/psicológica) es una posición de obediencia que rechaza la responsabilidad subjetiva.
- **Enunciado vs. Enunciación**: La clínica exige no quedarse con la literalidad de lo que se dice (el enunciado, ej. "me quiero matar" dicho al pasar), sino leer desde dónde y cómo se dice (la enunciación).
- **Segregación clínica**: Evitar pacientes complejos por miedo a problemas legales (como se ve en ciertos discursos de redes sociales) es un efecto segregativo y anti-ético. La verdadera responsabilidad asume el riesgo del caso singular, como hacía Lacan según Roudinesco.

M1.04. Fariña, M. "Tatuajes en la escuela primaria".

El análisis de Juan Jorge Michel Fariña sobre el primer episodio de la serie animada *Los Simpson* utiliza la escena del tatuaje trunco del pequeño Bart como una lección inaugural para explicar la transmisión de la ética, la estructura de la subjetividad y el funcionamiento de la ley en la especie humana. En la secuencia narrativa, Bart, en un raptó de amor hacia su madre Marge, decide grabarse en el brazo un tatuaje permanente con un corazón y la palabra "Mother" (madre). Sin embargo, Marge irrumpe intempestivamente en el local y detiene la tarea del tatuador en mitad del proceso, dejando sobre la piel de su hijo un texto incompleto: la palabra "Moth", que en inglés significa polilla. Esta intervención no calculada genera un desplazamiento significativo cómico e hilarante, condensado en el neologismo *moth(er)*, que convierte a la madre en una polilla en el corazón del niño.

Desde la perspectiva psicoanalítica, la irrupción de Marge ejecuta la función universal de la interdicción o castración simbólica. Marge suspende un acto considerado excesivamente precoz para un niño: una declaración de amor indeleble, inalterable y permanente hacia la figura materna. La razón estructural de esta prohibición reside en que Marge tiene localizado su objeto de deseo en Homero —quien, aunque ausente físicamente de la escena, está representado simbólicamente—, no dejando lugar para la pretensión de fusión de Bart. Al interceptar el destino incestuoso del tatuaje original y desviarlo hacia una polilla, la madre ejerce la función de la Ley, abriendo la condición de posibilidad para que en el futuro el niño pueda dirigir su amor hacia cualquier otra mujer que no sea ella.

Esta viñeta permite articular la tríada de categorías lógicas que fundamentan la ética: lo Universal, lo Particular y lo Singular. La dimensión de lo Universal no se corresponde con lo "general" ni con un "todos" cuantitativo; tal como lo precisó Jacques Lacan en su segundo seminario, lo general refiere a características anatómicas compartidas por la especie (como ser bípedos o tener dos ojos), mientras que lo Universal es la estructura del sistema simbólico y de la Ley de Interdicción como rasgo propio de la especie hablante. Por su parte, lo Particular constituye el campo de los códigos compartidos, la cultura y la lengua que sirven como soporte material e histórico para que el orden simbólico encarne. En el ejemplo, lo particular está representado por el idioma inglés (que soporta el equívoco intraducible entre *moth* y *mother*), el símbolo cultural del corazón de Cupido como alegoría del amor y el mito occidental del Complejo de Edipo. Finalmente, lo Singular es la marca significativa irrepetible e incalculable que se inscribe en la historia del sujeto; la fórmula *moth(er)* funcionará como una marca indeleble que organizará para siempre el fantasma y las condiciones de goce de Bart.

Asimismo, el texto establece una distinción entre las variaciones morales contingentes y la estructura ética atemporal. Mientras que la aceptación social del tatuaje en niños puede cambiar según las épocas y modas (dimensión moral y estética), la objeción a una fijación incestuosa permanente hacia la madre responde a una necesidad de estructura psíquica que trasciende el tiempo (dimensión ética). Finalmente, este proceso se comprende mediante una inversión dialéctica de matriz hegeliana: la afirmación inicial del niño por sellar su amor hacia la madre sufre la negación de la interrupción materna, dando paso a una negación de la negación en la fórmula *moth(er)*. De este modo, el aparente fracaso del tatuaje constituye su verdadero triunfo estructural, pues restituye a Bart como hijo dentro del orden simbólico y lo libera para la vida.

M1.01. Ariel, A. "Una poética del Estilo".

El texto de Alejandro Ariel propone una clarificación conceptual orientada a desorganizar los falsos pares de oposición tradicionales que articulan el debate sobre la existencia humana, tales como Moral y Ética, Estilo y Estética, Pasión y Deber, o Sujeto y Estado. Tras el advenimiento del Estado moderno y de la ciencia, la pregunta por el sujeto y la existencia fue asumida inicialmente por el arte a través del teatro y la literatura. Para situar el acto creador, el autor distingue en primer lugar la moral del orden ético. La moral se define como aquello pertinente a la conducta social de un sujeto entre otros, expresando los deberes frente al Estado y la ley. La moral es temática, es decir, se aplica a contenidos específicos; es temporal e histórica, variando según cada época; y es culpable, en tanto establece una deuda constante con el legislador interno que cada individuo cultiva. En este sentido, la moral representa la pereza de la existencia, un adormecimiento confortable en las formas cotidianas y en los signos brindados por el Otro, estructurado bajo oposiciones necesarias para la convivencia social como bueno o malo, verdadero o falso, y sí o no.

En contrapunto con la moral, la ética se define no por la conducta social, sino como la posición de un sujeto frente a su propia soledad, revelando lo que se está dispuesto a afirmar y a firmar sin garantías externas. La ética propone un plano de existencia atemporal, atemático y existencial que excede la época en la que el sujeto está condenado a vivir. Ariel enfatiza que la ética y la moral forman un falso par de oposición porque no se excluyen ni se complementan; la ética pertenece a lo que, siguiendo al escritor Alfred Jarry, denomina el orden suplementario. Lo suplementario no se opone al orden social ni pretende completarlo mediante políticas culturales, sino que lo excede y lo desorganiza cada vez que se manifiesta un acto de sujeto, despertando al individuo del adormecimiento normativo.

En el ámbito del arte, el autor traslada esta misma lógica a la distinción entre estética y estilo. La estética constituye el fundamento del orden social que establece las condiciones de posibilidad para la experiencia de la belleza en una época determinada. Al igual que la moral, la estética es temporal y temática; aunque constituye un freno indispensable contra el caos informe, representa un crimen contra la singularidad del individuo al proponer una norma igualadora para todos. Ariel diferencia dos modalidades estéticas: la estética del saber y la estética de la muerte. La estética del saber, asociada al clasicismo y a la apariencia apolínea, intenta capturar la permanencia y eternidad de la belleza ideal, reconciliando al sujeto con el deber moral; en ella el lenguaje funciona como un muro infranqueable y su desarrollo da lugar a escuelas y discípulos. Por el contrario, la estética de la muerte, vinculada a las vanguardias históricas, intenta capturar el

punto de transformación, el intervalo y la grieta irrepresentable de la existencia — como la representación del grito o el misterio de la propia muerte—. Esta estética conmueve lo instituido desde la presencia de un sujeto singular y no hace escuela, dejando una marca solitaria que frecuentemente es absorbida más tarde por el mercado o la cotidianidad.

Frente a la estética, el estilo se define como la posición del sujeto frente a su soledad en el acto creador que se atreve a ir más allá de la belleza. Mientras que la belleza estética brinda la protección de un molde seguro entre otros, el estilo induce una posición que trasciende la vida biográfica y personal del artista, produciendo existencia atemporal. La creación es siempre inocente y al mismo tiempo culpable frente a las normas estéticas de su tiempo, razón por la cual el reconocimiento artístico suele llegar de manera póstuma desde la lápida. El acto creador implica lo inhumano de la existencia: no busca compasión, no persuade, no ahorra el escándalo ni convoca rebaños o seguidores. El estilo irrumpe como un despertar que desgarrar la utilidad habitual de las cosas —tal como Marcel Duchamp al colocar un peine inutilizado en una pintura—, limitándose a dejar trazados silenciosos e imborrables en el silencio real del mundo.

M1.03. **Lewkowicz, I.** "Particular, Universal, Singular. (Cap. IV)".

El capítulo escrito por Ignacio Lewkowicz aborda la clarificación conceptual de las categorías de Universal, Particular y Singular para el campo de la ética, desarticulando los obstáculos derivados de la aparente transparencia de estos términos en el lenguaje cotidiano. El autor advierte que las intuiciones cuantitativas —aquellas que identifican lo singular con "uno solo", lo particular con "unos cuantos" y lo universal con "todos"— son profundamente insuficientes y contraproducentes. En el terreno de la ética y la lógica, un individuo no es una singularidad por el solo hecho de ser "uno", sino un término previsible e individualizado puesto en serie dentro de un conjunto por las propiedades generales que lo definen. La aprehensión rigurosa de estos conceptos exige acudir a la teoría pura de las multiplicidades y a la axiomática de conjuntos.

Desde la perspectiva de la teoría de conjuntos, existir equivale a pertenecer a un conjunto determinado por propiedades estructurantes o leyes de base. El resultado más sólido de la matemática contemporánea demuestra que no es posible formular una propiedad lógica capaz de albergar la totalidad de las cosas sin caer en una inconsistencia radical; por consiguiente, el "Conjunto Universal" no existe como una entidad cerrada. Todo "universo", "situación" o "código de leyes" que se presenta inicialmente como completo es en realidad un Particular precario, un todo restringido cuya coherencia interna depende de exclusiones implícitas y ciegas que el propio lenguaje de la situación desconoce.

Esta definición permite establecer una distinción crucial entre la transgresión y la singularidad. La ley que organiza una situación ya tiene previstos los lugares y nombres para los comportamientos que la violan; la transgresión está codificada por la propia norma, no excede los recursos simbólicos instituidos ni pone en suspenso la consistencia del sistema. Por el contrario, la Singularidad se define por su sustracción al régimen del "uno": es la presentación de un elemento incalificable por el lenguaje de la situación que hace desfallecer las capacidades clasificatorias de la ley vigente. En la irrupción de una singularidad, las legalidades constituidas fracasan y la supuesta totalidad del universo previo queda destotalizada y expuesta como meramente particular.

Correlativamente, el estatuto de lo Universal se desplaza. El Universal deja de ser concebido como una masa gigantesca o un contenedor estático para redefinirse como la potencia de exceso, desborde y suplementación. Es el gesto ético que, tras la destotalización provocada por la singularidad, va más allá del universo particular restringido para fundar una nueva ley más amplia. El universo inicial se revela retroactivamente como particular, mientras que el carácter de universalidad se traslada al movimiento de desbordar dicho universo y reordenarlo.

Asimismo, Lewkowicz enfatiza que las singularidades no existen "en persona" ni constituyen objetividades dadas en trascendencia para ser observadas desde la distancia por un sujeto del conocimiento. Las singularidades son procesos estrictamente situacionales e inmanentes que varían según el campo en que operan: representan un exceso sobre lo socialmente existente en el terreno sociohistórico, sobre lo teóricamente transmisible en la clínica psicoanalítica, sobre las regularidades de intereses en la política o sobre las codificaciones de género en la estética. La posibilidad de que una singularidad se constituya depende absolutamente de la intervención subjetiva, entendida como el trabajo activo de lectura y nominación que detecta la vía muerta o *impasse* de la cadena simbólica, inventa enunciados para nombrar lo que había estado excluido a priori y suplementa la realidad de la situación incorporando una nueva universalidad.

M1.08. Michel Fariña. "El doble movimiento de la ética contemporánea. Una ilustración cinematográfica".

El trabajo de Juan Jorge Michel Fariña aborda la transmisión y el ejercicio de la ética profesional contemporánea mediante la conceptualización de un doble movimiento dialéctico que articula las dimensiones de lo Particular y lo Universal-Singular. El primer movimiento de la ética marca el tránsito de los juicios morales ordinarios hacia el universo de conocimientos normativos disponibles en una disciplina, lo que se denomina el "estado del Arte". Este nivel, sintetizado en los códigos deontológicos y en las pautas de conducta profesional, establece de antemano el "qué debería hacer" el terapeuta ante dilemas clínicos previstos. Sin embargo, la dimensión ética no queda agotada en el cumplimiento de estas pautas; requiere de un segundo movimiento, suplementario del anterior, que da cuenta de las singularidades en situación. Este segundo movimiento se activa ante escenarios dilemáticos para los cuales no existe un saber técnico previo disponible, siendo la situación misma la que desborda el marco de la norma y exige responder al "qué hacer" allí donde la experiencia clínica excede todo cálculo predeterminado.

Para ilustrar esta dialéctica sin pretensiones de verosimilitud empírica, el autor analiza metodológicamente dos escenas de la película *Deconstructing Harry* de Woody Allen. La primera situación presenta a una terapeuta que atiende en el consultorio de su casa mientras mantiene una violenta discusión matrimonial, provocada porque su marido tuvo una aventura amorosa con una de sus pacientes. Al evaluar este escenario desde la perspectiva del primer movimiento de la ética, la conducta de la terapeuta constituye una transgresión deontológica flagrante: la pauta sobre competencia y conflictos personales prohíbe explícitamente prestar servicios profesionales cuando el terapeuta atraviesa crisis emocionales graves que alteren su juicio. Bajo la lógica del código, el análisis concluiría en la descalificación de la profesional.

No obstante, al examinar la salida de la situación mediante el segundo movimiento de la ética, se revela una eficacia clínica inesperada. El paciente en sesión, el Señor Farber, padece una vacilación obsesiva y se encuentra atrapado en una posición pasiva de "tercero excluido" frente a la dinámica de su esposa y su cuñado. A lo largo de la sesión, la terapeuta intenta desprolijamente separar los espacios, pero en un momento crítico comete un "equivoco" de lugares: sentada en su sillón de analista a espaldas del paciente, grita hacia la otra habitación la exigencia dirigida a su marido: "¡Te vas hoy mismo!". Debido a la ambigüedad lingüística del enunciado y a la posición física desde la cual habla la terapeuta, el Señor Farber escucha la frase en su propia dimensión transferencial y rompe en llanto. Esta

intervención, desprovista de todo cálculo técnico deliberado, opera un corte eficaz sobre la vacilación del paciente, acotando la serie de repeticiones de goce en las que se encontraba atrapado.

El autor aclara que este análisis no busca redimir las desprolijidades formales de la terapeuta ni otorgarle una condición de virtud personal. Ello responde a un principio ético fundamental: la inexistencia del "ser ético". La ética no constituye un atributo permanente de la personalidad ni una identidad profesional estática; nadie es en sí mismo más o menos ético, sino que la dimensión ética emerge únicamente *a posteriori* en la singularidad de un acto situado.

Como contrapunto, la segunda viñeta del film presenta al analista de Harry, el protagonista. Este terapeuta despliega un encuadre formalmente impecable, con un consultorio elegante, modales sobrios y una voz cálida que cumple con el decoro profesional. Sin embargo, durante la sesión, el analista dedica quince minutos a recitarle a Harry un cuento que el propio paciente había escrito, ofreciendo una interpretación calculada e impartiendo finalmente un consejo paternalista sobre su vida familiar. Aunque Harry sale reconfortado, la sesión resulta clínicamente estéril, pues estuvo guiada por la seducción narcisista del terapeuta en lugar de responder a la posición del paciente. Mientras que la sesión del Señor Farber concluyó entre lágrimas pero con un efecto transformador real, la de Harry fue un despliegue de confort sin consecuencias subjetivas. El texto concluye enfatizando que la verdadera eficacia de la interpretación analítica reside en la ausencia de cálculo técnico y en la capacidad de operar en la clínica sin la falsa seguridad de las certezas normativas.

M1.10. Sófocles. "Antígona".

La tragedia *Antígona* de Sófocles articula su argumento alrededor del enfrentamiento ineludible entre el orden político-estatal y el orden moral-religioso, desencadenado en la ciudad de Tebas tras la muerte simultánea de los hermanos Eteocles y Polinice. Tras la victoria sobre el ejército invasor argivo, Creonte asume el trono tebanos y promulga un edicto que establece honores fúnebres para Eteocles, defensor de la patria, pero prohíbe severamente la sepultura y el llanto para Polinice, calificado como traidor. Esta decisión gubernamental contraviene de manera directa las costumbres tradicionales y el deber sagrado de la *philia* (el amor filial y fraternal), situando la ley humana positiva dictada por el soberano en rumbo de colisión frontal con los imperativos religiosos comunitarios.

Ante la proclama de Creonte, Antígona decide desobedecer abiertamente el decreto real para cumplir con el rito funerario de su hermano, solicitando la ayuda de su hermana Ismena. Ismena encarna la postura de la sumisión pragmática y la resignación ante la autoridad masculina y el poder del Estado, alegando la incapacidad de las mujeres para luchar contra los hombres en el poder. En contraste, Antígona asume la responsabilidad de manera individual y temeraria, declarando que prefiere morir cumpliendo un deber sagrado antes que vivir en la impiedad. Cuando un centinela descubre que el cadáver de Polinice ha sido cubierto simbolicamente con un fino polvo y libaciones rituales, Creonte reacciona con cólera y sospechas de conspiración movida por el dinero, revelando desde el principio un sesgo autoritario que confunde el bien común con la obediencia ciega a su persona.

Tras ser sorprendida en un segundo intento de sepultura, Antígona es conducida ante Creonte. En la confrontación medular de la obra, la joven justifica su desobediencia civil apelando a los *agrapsoi nomoi* (las leyes no escritas e inmutables de los dioses), principios eternos superiormente constitutivos que ningún decreto pronunciado por un mortal tiene el poder de anular. Antígona afirma que no nació para compartir el odio, sino el amor, sosteniendo que en la morada de Hades (el inframundo) rige la igualdad de derechos para los muertos, independientemente de sus actos políticos en vida. Creonte, dominado por la *hubris* (la soberbia desmedida e inflexibilidad que ciega la razón), interpreta la postura de Antígona como un desafío intolerable a su autoridad real y a su condición masculina, condenándola a ser sepultada viva en una caverna rocosa para evitar la mancha directa de sangre sobre la ciudad.

El conflicto se profundiza con la intervención de Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, quien intenta razonar con su padre. Hemón aboga por la *phronesis* (la sensatez, prudencia y apertura mental), señalando que el pueblo

de Tebas compadece en secreto a Antígona y la considera digna de gloria por su acto piadoso. Sin embargo, Creonte desestima los consejos de su hijo debido a su juventud y afirma despóticamente que la ciudad pertenece únicamente a quien la gobierna. La negativa del rey a escuchar la opinión pública y su obstinación en considerar la discrepancia como una afrenta personal consolidan su transformación de un gobernante protector en un tirano ciego ante la realidad.

El punto de inflexión definitivo ocurre con la llegada del adivino ciego Tiresias, quien revela horribles presagios: los altares de Tebas están infectados por los restos fecales y carnosos de Polinice transportados por aves y perros, lo que ha provocado el rechazo de los dioses a los sacrificios y oraciones de la ciudad. Tiresias advierte a Creonte que la terquedad es la verdadera causa de la locura y le profetiza que, por haber enviado a un ser vivo a las profundidades de la tierra y retener a un cadáver insepulto, pagará la vida de su propia estirpe a manos de las Erinas (las divinidades vengadoras). Aunque inicialmente el rey acusa al adivino de actuar movido por la codicia, el terror generado por las palabras de Tiresias y las exhortaciones del Coro de ancianos tebanos terminan por doblegar su resistencia, obligándolo a intentar una rectificación tardía.

El intento de enmienda de Creonte resulta infructuoso ante la celeridad de la tragedia. Al llegar a la tumba subterránea tras haber dado sepultura a Polinice, Creonte descubre que Antígona se ha ahorcado con su propio cinturón. Hemón, abrazado al cuerpo inerte de su prometida y sumido en la desesperación, encara a su padre, le escupe y, tras errar un golpe contra él, se atraviesa el costado con su propia espada. La noticia del suicidio de Hemón provoca a su vez el suicidio de la reina Eurídice, esposa de Creonte, quien se apuñala en el palacio maldiciendo a su marido como el asesino de sus hijos.

La obra concluye con la ruina absoluta de Creonte, quien regresa al palacio cargando el cadáver de su hijo y enfrentando el cuerpo sin vida de su esposa. Destrozado por el remordimiento y despojado de su altivez, el soberano reconoce ser el único culpable de la catástrofe familiar y suplica la muerte para poner fin a su sufrimiento. El Coro cierra la tragedia articulando la enseñanza fundamental del drama: la prudencia y el respeto a las leyes divinas constituyen la primera fuente de la felicidad humana, mientras que las palabras insolentes de los espíritus orgullosos reciben como castigo infortunios devastadores que solo enseñan el juicio en la vejez.

M1.06. Michel Fariña. "El interés ético de la tragedia (Cap. V)".

El capítulo escrito por Juan Jorge Michel Fariña fundamenta la necesidad de acudir a la textura narrativa de la tragedia clásica para poner a trabajar las categorías lógicas de la ética, utilizando la historia de Antígona como eje conceptual. La exposición inicia con un homenaje a la directora teatral María Visconti y a su puesta en escena de *Antígona Vélez* —la recreación pampeana de Leopoldo Marechal— en la Argentina de mil novecientos setenta y seis. Este relato personal ilustra la función del arte dramático como un canal simbólico para despedir a los muertos y procesar la irrupción de la tragedia histórica en el cuerpo social.

Para delimitar la especificidad de la tragedia, el autor establece un contraste inicial con el drama o melodrama convencional, comparando a Antígona con *Antonella*, la heroína de folletín televisivo. En el melodrama, la protagonista encarna una bondad maniquea y pasiva que se arrastra por el fango confiando ciegamente en que la Providencia o un "príncipe azul" llegará a último momento para rescatarla y garantizar un final feliz. Por el contrario, apoyándose en la versión de Jean Anouilh, el texto define a la tragedia como una estructura limpia, ineludible y despojada de "cochina esperanza". En la tragedia no hay accidentes ni salvaciones milagrosas; una vez que el resorte de la acción se suelta a partir de una breve pregunta o un deseo de honor, la trama marcha sola y los personajes deben responder por las consecuencias de sus decisiones hasta el final.

La fundamentación teórica de este género se remonta a la *Poética* de Aristóteles. El filósofo griego define la tragedia como la imitación de una acción de carácter elevado y completa que, moviendo a compasión y temor, opera en el espectador la purificación propia de estos estados emotivos. Esta definición se sostiene en tres términos esenciales: la *mimesis*, entendida no como una mera copia pasiva sino como una re-producción activa de la vida; la *praxis*, que alude a una acción humana fundamentada en la *proáieresis* o elección consciente del sujeto; y la *kazársis*, conceptualizada como el alivio, apaciguamiento o descarga emocional e intelectual que experimenta el público al identificarse con las vicisitudes del héroe. Aristóteles aclara que la tragedia no imita a seres humanos abstractos, sino momentos de acción y de vida. En contrapunto con la tragedia, que presenta personajes superiores al promedio, el autor menciona a la comedia —ejemplificada en el cinismo de Merlina en *Los locos Addams II*— como un género que muestra tipos humanos inferiores para desbaratar las ilusiones de la moral burguesa y desenmascarar las certezas del Otro.

Para comprender las coordenadas del conflicto que desemboca en el acto de Antígona, el capítulo examina los antecedentes mitológicos de la contienda entre los hijos de Edipo: Etéocles y Polinices. En tragedias como *Los siete sobre Tebas* de

Esquilo y *Las fenicias* de Eurípides, el enfrentamiento militar entre los hermanos mellizos por el trono de Tebas es representado en una clave estrictamente especular e imaginaria. La batalla se despliega puerta por puerta de forma simétrica: a cada capitán y dios grabado en el escudo del ejército agresor argivo le corresponde un defensor y un dios equivalente en el bando tebano ("águila contra serpiente"). Esta simetría demuestra que la disputa entre Etéocles y Polinices se mantiene en el plano de un conflicto moral entre particularidades; las razones de un hermano no son superiores a las del otro, pues la ambición de poder y la violencia coexisten distribuidas en ambos bandos.

El enfrentamiento culmina con la muerte recíproca de los hermanos en combate singular. Es tras la llegada de los cadáveres cuando irrumpe la figura del pregonero con el edicto de Creón, por el cual se ordena sepultar con honores a Etéocles como defensor de la patria y condenar el cuerpo de Polinices a quedar insepulto a la intemperie para ser devorado por los perros. De este modo, lo que era un conflicto imaginario y reversible entre particularidades morales se transforma en un efecto particularista, donde la facción gobernante pretende aniquilar la condición humana del rival vencido. Es precisamente sobre la ruptura de esta simetría y ante la imposición del edicto despótico donde concluyen los prolegómenos del mito y se abre el escenario para el acto ético e insustituible de Antígona.

M1.01. Gutiérrez, C. "Antígona y el rito funerario. (Cap. VII)".

El capítulo de Carlos Gutiérrez aborda el valor ético y psicoanalítico del rito funerario a través del estudio de la *Antígona* de Sófocles, apoyándose en las contribuciones de George Steiner y en las lecturas desarrolladas por Jacques Lacan en sus seminarios VI (*El deseo y su interpretación*) y VII (*La ética del psicoanálisis*). El texto inicia contextualizando el redescubrimiento de la tragedia griega desde el siglo XVIII, destacando la versión alemana de Friedrich Hölderlin como el punto de partida de una extensa serie de reescrituras literarias. Sin embargo, el análisis central se detiene en una versión contemporánea específica: la *Antígona* escrita por Jean Anouilh durante la ocupación nazi en París. La confrontación entre el texto clásico y la versión moderna permite ilustrar lo que Lacan calificó provocativamente como la "pequeña Antígona fascista" de Anouilh, una obra que, si bien gana en belleza estética y ambientación histórica, termina anulando el núcleo trágico y ético del mito original.

En la adaptación de Anouilh, el personaje de Creón encarna un despotismo estatal absoluto donde las razones de Estado reducen la insepultura de Polinice a un simple "lío político". En este modelo de poder, Creón se ubica como el autor que antecede a la ley y concibe a sus gobernados como una masa anónima a la que hay que dominar por la fuerza. La gravedad de esta posición política y ontológica reside en el aplastamiento de la subjetividad: Creón llega a afirmar que en la tempestad política los sujetos pierden su nombre, volviendo a los individuos intercambiables al punto de seleccionar arbitrariamente el cadáver menos destruido para otorgarle honores fúnebres bajo el nombre de Etéocles y condenar al otro como traidor. En esta perspectiva, la palabra carece de verdad y funciona como un mero engaño, mientras que el rito sagrado del entierro es calificado como un simulacro absurdo. Por su parte, la Antígona de Anouilh sufre una degradación equivalente: su rebeldía se distancia del acto ético trágico para convertirse en una postura psicológica y burguesa de rechazo adolescente hacia la felicidad cotidiana, fascinada por una dimensión estética de la muerte y coincidiendo con Creón en calificar la sepultura de su hermano como un hecho insensato.

Frente a esta versión desacralizada, el psicoanálisis restituye el valor estructural del enfrentamiento entre Creonte y Antígona como un choque entre dos legalidades irreconciliables: la ley de la ciudad frente a la ley del deseo y de los dioses. Para comprender la función del rito funerario, Gutiérrez recurre a las lecciones de Lacan sobre la dinámica del duelo en relación con la tragedia de *Hamlet*. Lacan establece que el trabajo de duelo funciona como el reverso de la forclusión (*Verwerfung*) — mecanismo psicótico por el cual aquello que es rechazado en el orden simbólico reaparece en lo real—. En el duelo ocurre el proceso inverso: la pérdida irreparable

de la persona amada genera un agujero en lo Real que no puede ser colmado por ningún objeto concreto, obligando a la cultura a movilizar la totalidad del orden significante (el Logos) mediante la ceremonia pública de la sepultura.

El rito funerario no es un mero formalismo ni una costumbre privada de la esfera familiar, como pretendía la lectura hegeliana, sino un acto de carácter público impulsado por la comunidad para inscribir la falta y preservar el "registro del ser" del difunto, inmortalizando su Nombre en la cadena generacional más allá de cualquier juicio moral o histórico. Cuando este dispositivo simbólico falla o es interceptado por el poder —tal como ocurre con el asesinato del padre de Hamlet, con la insepultura de Polinice o, en la historia argentina reciente, con la desaparición forzada de personas perpetrada por el Terror de Estado—, la imposibilidad de tramitar el duelo impide suturar el agujero en lo Real. En consecuencia, el muerto retorna de forma siniestra bajo la figura de espectros, almas en pena o sombras errantes que reclaman su inscripción simbólica.

Es en esta hiancia donde se sostiene la postura de Antígona en la obra de Sófocles. Lacan la define como la "guardiana del ser del criminal como tal", pues su reclamo por la sepultura de Polinice prescinde de cualquier valoración sobre el bien o el mal que su hermano haya cometido en vida. Para Antígona, Polinice representa un objeto único e insustituible; a diferencia de un marido o de un hijo, a quienes podría reemplazar tras su pérdida, la muerte previa de sus padres convierte al hermano en un ser irrepetible en la cadena del deseo. Ante la negativa de Creonte de permitir el entierro público, la dimensión simbólica queda obturada y Antígona no puede metaforizar la pérdida. Al no ceder en su deseo y rechazar los pactos de la polis, la heroína realiza el sacrificio de su propio ser, entregándose de manera directa y sin mediaciones a la *âtê* o fatalidad trágica de su estirpe, demostrando que la presencia misma del lenguaje exige respetar el límite sagrado que dignifica la existencia humana hasta después de la muerte.

M2.12. **Salomone, G. Z.** "Consideraciones sobre la ética profesional. Dimensión clínica y campo deontológico - jurídico".

En su texto *Consideraciones sobre la Ética profesional: Dimensión clínica y campo deontológico-jurídico*, Gabriela Z. Salomone problematiza la tendencia habitual a tomar la ética profesional como sinónimo de deontología. La autora sostiene que reducir la ética al cumplimiento de pautas normativas genera una división indialéctica en el ejercicio profesional: por un lado, se configura un profesional obligado a responder a los deberes de ciudadano y a las leyes sociales centradas en un sujeto de derecho; por otro, un clínico que opera con el sufrimiento psíquico y la transferencia al margen de la norma. Para superar esta falacia, Salomone propone establecer la ética profesional en su doble dimensión: la confluencia y tensión creativa entre el **campo deontológico-jurídico** (la normativa y los deberes profesionales) y la **dimensión clínica** (la perspectiva fundada en la lógica del sujeto y la singularidad en situación).

Salomone demuestra que ambas dimensiones se organizan sobre lógicas disímiles y convocan al profesional desde posiciones muy diferentes. El campo deontológico-jurídico opera en la lógica de lo *particular* y lo general; se articula como un universo cerrado que busca regular «para todos» los casos y circunstancias posibles a través de pautas estandarizadas que condensan los valores morales y consensos de una época (tales como la confidencialidad, la autodeterminación, la autonomía y el consentimiento informado). Por el contrario, la dimensión clínica introduce la lógica de lo *singular* y del sujeto del inconsciente. Apoyándose en las formulaciones de Freud y Lacan, la perspectiva clínica se funda en la lógica de la castración y en la estructura del *no-todo* (la falta estructural en lo simbólico), reconociendo que ninguna norma ni saber acumulado de antemano puede recubrir o anticipar de forma exhaustiva la singularidad de un ser humano en situación.

A través de investigaciones empíricas, Salomone identifica dos posiciones reduccionistas frecuentes entre los profesionales: una postura legalista que busca garantías infalibles en la letra rígida del código, y una postura opuesta que descarta por completo las normativas vigentes amparándose en argumentos puramente «clínicos». La autora critica ambos extremos demostrando que el propio universo normativo contiene puntos de inconsistencia estructural que exigen interpretación. Por un lado, los códigos incluyen normas de excepción —como la suspensión del secreto profesional ante la «justa causa» o el «daño para sí o para terceros»— que enfrentan principios entre sí (como la intimidad individual frente a la seguridad pública, o la autonomía frente a la beneficencia). Por otro lado, la confrontación con un caso real demuestra que la aplicación de la norma nunca es automática;

mediante la comparación entre una viñeta donde un paciente anuncia un homicidio inminente (el caso Tarasoff) y otra donde un paciente con VIH mantiene relaciones sin protección, Salomone evidencia que las variables únicas de cada situación (como la responsabilidad de los terceros o el riesgo de discriminación) obligan al profesional a interpretar y ponderar el código en lugar de aplicarlo como un algoritmo.

Esta necesidad de interpretación marca la diferencia abismal entre una *posición moral* y una *posición ética*. La posición moral aborda el código desde un acatamiento autómata, buscando una garantía absoluta en la norma («solo obedecí el código») para eludir la propia responsabilidad y velar la inconsistencia del campo normativo. En cambio, la posición ética acepta la indeterminación radical y la inconsistencia del universo de las reglas. Sustentada en la lógica de la castración, la posición ética exige un gesto de *suplementación*: el profesional no obedece ciegamente ni rechaza irresponsablemente la norma, sino que la interpreta en situación, asumiendo la responsabilidad de la decisión sin refugiarse en certezas dogmáticas.

Finalmente, el texto articula cómo la postura del profesional incide directamente en el paciente, diferenciando la *responsabilidad jurídica/moral* (la rendición de cuentas ante la ley social y la sanción externa) de la *responsabilidad subjetiva*. Cuando un terapeuta levanta el secreto profesional basado únicamente en la obediencia moral, la intervención se limita a confrontar al paciente con la ley positiva y el castigo, ubicando al terapeuta en el rol de ciudadano acusador. Por el contrario, cuando la suspensión de la confidencialidad se fundamenta en una posición ética que evalúa las implicancias clínicas, la intervención busca enlazar el acto del paciente con la ley simbólica. Elevar la norma jurídica a la categoría de prohibición estructurante propicia una *rectificación subjetiva*, promoviendo que el paciente se interpele y responda por la verdad de su propio acto. Salomone concluye que la ética profesional alcanza su verdadera dimensión cuando el clínico, lejos de ampararse en el automatismo normativo o en el aislamiento analítico, sostiene la intersección de ambos campos para favorecer la responsabilidad subjetiva tanto en su propia práctica como en el sujeto sobre el que interviene.

M2.14. **Salomone, G. Z.** “Responsabilidad profesional: Las perspectivas deontológicas, jurídica y clínica”.

En su texto *Responsabilidad profesional: las perspectivas deontológica, jurídica y clínica*, Gabriela Z. Salomone lleva a cabo una sistematización integral de la responsabilidad inherente al ejercicio de la psicología, examinando sus modulaciones a través de los campos deontológico, jurídico y clínico. La autora inicia definiendo la responsabilidad profesional como una obligación abarcativa que recae sobre la totalidad de las actividades reguladas por las leyes de ejercicio profesional (como la Ley 23.277 en Argentina), las cuales incluyen la práctica clínica, la docencia, la investigación, la emisión de informes y el desempeño de funciones periciales en el ámbito judicial. Los códigos de ética establecen que esta responsabilidad es multidireccional, abarcando compromisos hacia los usuarios de los servicios, el público en general, la disciplina y la ciencia.

Esta convergencia configura una *responsabilidad social* mediante la cual el profesional utiliza su saber para promover políticas públicas, prevenir alteraciones de la salud mental y garantizar los Derechos Humanos reconocidos constitucional e internacionalmente. Desde la perspectiva deontológica, la responsabilidad profesional se articula a través de códigos de conducta que regulan la práctica mediante deberes que resguardan a los destinatarios de las intervenciones, conceptualizados en este campo como «sujetos de derecho». Salomone destaca la distinción estructural entre los *Principios Generales* de los códigos —los cuales representan aspiraciones ideales y objetivos deseables que expresan el espíritu ético de la profesión, como el respeto por la dignidad, la privacidad, la autonomía y la no-discriminación— y las *Disposiciones Deontológicas*, que constituyen reglas de conducta de cumplimiento obligatorio. Estas reglas fijan deberes precisos en áreas clave como la confidencialidad (mediante el secreto profesional), la autonomía (mediante el consentimiento informado) y la exigencia de una idoneidad científica mantenida a través de la capacitación y actualización permanente sobre el estado del arte.

Desde la perspectiva jurídica, la responsabilidad profesional se enmarca en el ordenamiento legal del Estado de Derecho, donde el incumplimiento de las obligaciones contractuales o legales genera responsabilidad civil y penal. Salomone aclara que el psicólogo asume una «obligación de medios, no de resultados», lo que significa que debe poner todo su conocimiento, prudencia y pericia técnica al servicio del paciente, sin garantizar la curación como un resultado inexorable. La transgresión de estas obligaciones configura la *mala praxis*, un concepto jurídico que refiere a las acciones u omisiones que ponen en riesgo o dañan directamente bienes jurídicos protegidos por la ley (tales como la vida, la

salud, la intimidad o la autonomía). La responsabilidad civil derivada de la mala praxis (contemplada en el Código Civil argentino) obliga al profesional a reparar económicamente el perjuicio ocasionado, exigiéndosele un mayor deber de obrar con prudencia debido a la naturaleza especializada de su titulación.

Salomone detalla las cuatro modalidades jurídicas en que puede manifestarse la mala praxis: la *imprudencia*, definida sintéticamente como «hacer más de lo debido», consistente en un acto positivo realizado con osadía desproporcionada, falta de precaución o sin contar con el entrenamiento específico requerido para una técnica compleja (como indicar la externación precipitada de un paciente inestable); la *negligencia*, definida como «hacer menos de lo debido», caracterizada por un acto negativo de descuido o abandono de las pautas probadas de tratamiento (como omitir una interconsulta médica para descartar un Cuadro orgánico); la *impericia*, entendida como la falta total o parcial de los conocimientos científicos, técnicos o habilidades prácticas indispensables que se presuponen adquiridas con el título profesional (como cometer errores diagnósticos por incompetencia); y la *inobservancia de los reglamentos*, que implica el apartamiento u omisión de las leyes positivas, normas deontológicas u órdenes jerárquicas (como la confección deficiente de la historia clínica o la falta de implementación del consentimiento informado). Asimismo, la autora señala que las consecuencias de la mala praxis pueden derivar en responsabilidad penal por homicidio o lesiones culposas (arts. 84 y 94 del Código Penal), además de configurar delitos generales como el abandono de persona o la omisión de auxilio.

Finalmente, la autora sostiene que la responsabilidad profesional no se agota en el cumplimiento deontológico o en la prevención de la mala praxis jurídica, ya que ambos marcos abordan al individuo exclusivamente como un sujeto de derecho bajo categorías generales. La responsabilidad profesional debe incorporar necesariamente la *dimensión clínica*, la cual coloca al terapeuta frente al «sujeto del sufrimiento psíquico» dentro de las coordenadas singulares de la transferencia y el inconsciente. Mientras que el fuero jurídico evalúa la responsabilidad en términos de daño externo y reparación civil, la dimensión clínica exige un posicionamiento ético que atienda a los efectos subjetivos de cada decisión. Salomone concluye que, si bien los códigos de ética y las leyes constituyen guías de referencia indispensables para la práctica, funcionan como un marco que jamás podrá sustituir el discernimiento, el juicio interpretativo y la responsabilidad personal del profesional al tomar una decisión en situación.

M3.03. Calo, O. “La interacción del profesional con los códigos”.

En su ensayo *La interacción del profesional con los códigos*, Orlando Calo plantea la necesidad de construir una relación activa, reflexiva e interactiva entre el psicólogo y el corpus deontológico que regula su praxis. El autor define la *deontología* como el conjunto de los deberes que se imponen a los profesionales en el ejercicio de su actividad, condensados en leyes de ejercicio, reglamentos institucionales y códigos de ética que reflejan el consenso moral vigente de una sociedad. Calo enfatiza que la posición del profesional frente a este marco normativo no puede ser de *heteronomía* —entendida como una actitud de mera obediencia pasiva o acatamiento automático— ni de indiferencia. Por el contrario, la práctica exige un posicionamiento ético autónomo capaz de interrogar críticamente la letra del código, tomando decisiones desde una jerarquización de valores que integre la libertad y la responsabilidad subjetiva.

Calo fundamenta esta exigencia de interacción en la *incompletud estructural* de los códigos de ética. Resulta fácticamente imposible redactar un código completo capaz de prescribir la conducta a seguir ante todas las circunstancias futuras, puesto que la variedad de situaciones clínicas es infinita y la relación entre un caso real y la norma general requiere siempre de un acto interpretativo. Asimismo, dado que los valores son históricos y regionales, las normativas deben ser periódicamente revisadas por el colectivo profesional. Esta imposibilidad de contar con un reglamento perfecto no constituye una falencia, sino que funda la libertad y la potencia del profesional como sujeto ético, convocándolo a anteponer su compromiso personal y responsable por encima del automatismo prescriptivo.

Para ejemplificar esta posición reflexiva en la clínica, el autor examina minuciosamente la obligación del *secreto profesional* (confidencialidad). Apoyándose en formulaciones éticas sobre la salud, Calo distingue entre la *intimidad* y el *secreto profesional*. La intimidad es un valor en sí mismo, un derecho individual básico y el ámbito psíquico donde se despliega la constitución subjetiva; por ello, la defensa de la intimidad debe abordarse desde una actitud *principialista* o deontologista (defender el valor por su peso intrínseco). En cambio, el secreto profesional es únicamente un medio o instrumento para proteger esa intimidad, poseyendo un valor puramente utilitario o consecuencialista. Considerar la norma del secreto como un valor absoluto en lugar de un instrumento conduciría a situaciones donde el fin mismo (la intimidad y la vida) resultaría afectado. Por esta razón, los códigos establecen excepciones legítimas a la confidencialidad (como la *justa causa* para evitar un daño grave al paciente o a terceros, evidenciada en el caso Tarasoff; la legítima defensa del profesional ante denuncias injustas formuladas por el paciente; o la denuncia de

violaciones a los Derechos Humanos), dejando la decisión final reservada al discernimiento subjetivo del profesional («cuando a juicio del profesional interviniente...»).

De igual modo, Calo analiza críticamente la obligación de obtener el *consentimiento informado* del consultante. La *autonomía* personal representa el fin en sí mismo, mientras que la exigencia de consentimiento es el instrumento normativo diseñado para acotar el paternalismo asistencial y proteger la capacidad de decisión del individuo. No obstante, el autor advierte que aplicar la norma del consentimiento de manera rígida u obsesiva puede volver inoperante la práctica clínica y científica. En la investigación psicológica, ciertos diseños requieren el recurso al engaño temporal para garantizar la validez de los datos, lo cual el código autoriza siempre que se brinde una explicación posterior (*debriefing*). En el psicodiagnóstico, detallar previamente los parámetros de evaluación de una prueba invalidaría la novedad del estímulo y la confiabilidad del test. En la psicoterapia, pretender fundamentar el tratamiento en la sugestión para obtener la firma del paciente o asumir el consentimiento como un contrato rígido desconoce la naturaleza fluctuante de la transferencia y la resistencia, donde la disposición del consultante varía a lo largo de la cura.

Finalmente, Calo cuestiona la reciente tendencia de exigir la firma de *formularios burocráticos de consentimiento* en instituciones de salud, práctica importada junto con los seguros contra juicios por mala praxis como una respuesta defensiva ante la «industria del juicio». El autor señala que estos formularios suelen responder a la necesidad de profesionales y funcionarios de protegerse legalmente, más que al verdadero respeto por la autonomía del consultante. Introducir la firma de un documento legal en el encuadre terapéutico instala a un tercero institucional en la relación clínica, lo que puede alentar la desconfianza o alimentar supuestos paranoides en el paciente. Calo concluye que, si bien la profesión no puede existir sin códigos de ética, la deontología se desvitaliza sin la interacción continua de profesionales que, a través de su práctica crítica y su responsabilidad ética, actualizan la norma en cada intervención singular.

M2.03. Dominguez, M. E. "La singularidad en los códigos de ética. Ética y deontología".

En su texto *La singularidad en los códigos de ética*, María Elena Domínguez examina la articulación y tensión entre la deontología profesional y la ética de orientación psicoanalítica, analizando el estatuto de las normas escritas que regulan la práctica del psicólogo. La autora comienza rastreando la raíz del término *ethos* — en sus acepciones de «morada» y de «modo de ser» o «costumbre»— para diferenciar la ética concebida como ciencia del comportamiento moral de la *deontología*, término acuñado por Jeremy Bentham para definir la ciencia de los deberes y normas morales de una actividad social. Domínguez establece que la deontología legisla lo esperable en el plano de lo *Particular*, entendido como el conjunto de usos, costumbres, valores y códigos consensuados por una comunidad profesional en una época determinada. Por el contrario, la ética psicoanalítica, fundada en la premisa lacaniana de indagar la fidelidad al deseo inconsciente («¿has actuado en conformidad con el deseo que te habita?»), trasciende los ideales terapéuticos y el consenso moral. Esta ética opera en la lógica del «no-todo» y se sostiene en un «saber-hacer en acto» que renuncia a la pretensión de un saber absoluto o normativizador.

Para formalizar la relación de concordancia y discrepancia entre ambas dimensiones, el texto retoma la formulación de Ignacio Lewkowicz que define a las éticas como aquellas singularidades en las que se ponen en juego universales que exceden cualquier ley particular. Lo *Particular* constituye el código o universo de discurso compartido que sirve de común medida. Lo *Singular* representa aquello incalificable que se sustrae al régimen del «uno» e irrumpe desestructurando la legalidad del universo previo. Domínguez ilustra esta dinámica recurriendo a modelos de la teoría de conjuntos: por un lado, la deontología se asimila a la *teoría intuitiva de conjuntos*, la cual define universos normativos cerrados agrupados por propiedades o predicados comunes; cuando emerge una nueva singularidad no contabilizada por el código, el sistema particular se destotaliza y se ve forzado a «engordar» su predicado normativo para incorporar la nueva excepción en una constante revisión. Por otro lado, la ética se equipara a la *teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel*, la cual reconoce la incompletud estructural del universo y asume que la ley universal no puede deducirse *a priori*, sino que debe ser *decidida* e inventada por el sujeto implicado en la singularidad de la situación a través de una operación de suplementación.

Esta perspectiva teórica permite criticar las lecturas ingenuas o burocráticas de la deontología. Concebir el código de ética como un compendio rígido de leyes dispuestas sistemáticamente para resolver mecánicamente los obstáculos de la

técnica reduce la clínica a una mera obediencia reglamentaria. Para superar la aparente contradicción entre la rigidez normativa y la singularidad clínica, Domínguez propone reconceptualizar los códigos de ética como un «catálogo de singularidades decididas». Bajo este enfoque, las sentencias normativas no son mandatos dogmáticos ni universales absolutos, sino la cristalización histórica de respuestas producidas en el pasado cuando los practicantes se enfrentaron a la irrupción de situaciones clínicas insólitas. El código funciona así como un registro de experiencias instituyentes que conserva los valores y fundamentos éticos de la praxis.

La integración de los códigos deontológicos en la práctica psicoanalítica requiere de la mediación del «deseo del analista», conceptualizado como una posición de enunciación desujetada de ideales, prejuicios y goces personales que sostiene el acto analítico. El deseo del analista impide que el código sea leído desde una sumisión acrítica; en lugar de exigir un saber totalizador capaz de cubrir la totalidad de las situaciones posibles, el profesional realiza una lectura que sostiene la incompletud de la letra normativa. Esta posición produce un salto cualitativo que va desde el mero manejo técnico de las reglas hasta la invención clínica en acto. De este modo, el texto normativo se transforma en una herramienta de transmisión que hace lazo discursivo con la comunidad profesional, transmitiendo la experiencia clínica alrededor de un núcleo indemostrable e indomesticable: el deseo inconsciente.

En conclusión, Domínguez demuestra que la ética y la deontología se concilian cuando el código deja de leerse como un manual cerrado y se aborda como un compilado siempre abierto a nuevas suplementaciones. Cada vez que irrumpe una singularidad no calculada, el practicante es convocado a tomar posición mediante un acto de lectura que interpreta las pautas escritas a la luz de los fundamentos que las originaron. El corpus deontológico opera entonces como un vector ético de intervención que, lejos de ahogar la dimensión del caso por caso, resguarda la singularidad clínica y sostiene la transmisión de una práctica fundada en la responsabilidad del deseo.

M2.08. Ley de Salud Mental N.º 26657.

Sancionada en el año 2010 y reglamentada mediante el Decreto 603/2013, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 establece un marco normativo de orden público en Argentina destinado a asegurar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental, en concordancia con los tratados internacionales de jerarquía constitucional. La legislación conceptualiza la salud mental no como un estado estático o la mera ausencia de afecciones, sino como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una construcción social vinculada a la concreción de los derechos fundamentales. Rige como principio rector la presunción de capacidad jurídica de todas las personas. En ningún caso se puede formular un diagnóstico en salud mental basado en el estatus socioeconómico, la pertenencia política o religiosa, la identidad u orientación sexual, la falta de conformidad con valores morales prevalecientes, o la existencia de antecedentes de tratamiento o hospitalización. Asimismo, la ley establece de manera explícita que las adicciones y el uso problemático de drogas deben ser abordados como parte integrante de las políticas de salud mental.

El modelo asistencial instaurado por la norma se fundamenta en los principios de la Atención Primaria de la Salud y exige un abordaje interdisciplinario e intersectorial orientado al reforzamiento y promoción de los lazos sociales. Los equipos de salud deben integrar profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas pertinentes, garantizándose la igualdad de condiciones de todos los profesionales con título de grado para ocupar cargos de conducción y gestión institucional en función de su idoneidad. La ley prohíbe taxativamente la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes —públicas o privadas— y dispone la adecuación y sustitución progresiva de las existentes por una red de servicios comunitarios que abarca consultas ambulatorias, centros de atención primaria, hospitales de día, casas de convivencia, residencias protegidas, sistemas de atención domiciliaria y cooperativas de trabajo. Asimismo, se establece que las internaciones por motivos de salud mental deben realizarse exclusivamente en hospitales generales de la red pública y privada, considerándose un acto discriminatorio el rechazo de atención de pacientes por su condición psíquica.

Por principio general, rige la exigencia del consentimiento informado fehaciente para todo tipo de tratamiento o intervención, garantizándose al usuario el derecho a recibir información adecuada y comprensible, a tomar decisiones sobre su atención y a disponer de directivas anticipadas que pueden ser revocadas en

cualquier momento. Se prohíbe la realización de investigaciones clínicas o tratamientos experimentales sin un consentimiento otorgado fuera de contextos de restricción de la libertad. En cuanto a la terapéutica psicofarmacológica, la prescripción de medicamentos debe realizarse siguiendo las pautas de uso racional fruto de evaluaciones profesionales efectivas de médicos especialistas, prohibiéndose su administración de forma automática, como castigo, para suplir la necesidad de acompañamiento o por conveniencia de terceros. Por otra parte, la norma reconoce que la participación de los usuarios en actividades de laborterapia o talleres productivos que impliquen la comercialización de bienes o servicios exige el pago de una justa compensación económica para evitar situaciones de explotación laboral.

La internación es definida como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, excepcional y lo más breve posible, que solo procede cuando aporte mayores beneficios que las alternativas comunitarias, estando estrictamente prohibido indicarla o prolongarla para resolver problemáticas sociales o de vivienda. Para que proceda una internación involuntaria —entendida como una medida de extrema excepcionalidad— debe mediar la verificación de una situación de «riesgo cierto e inminente», definida por el decreto reglamentario como la contingencia o proximidad de un daño seguro, indubitable y verdadero que amenace la vida o la integridad física de la persona o de terceros, verificado mediante una evaluación actual del equipo interdisciplinario que no se reduzca a una clasificación diagnóstica. Toda internación involuntaria exige el dictamen firmado por al menos dos profesionales de distintas disciplinas que no tengan vínculo con el paciente (uno de los cuales debe ser obligatoriamente psicólogo o psiquiatra), la constatación de la ausencia de otra alternativa eficaz y la notificación obligatoria en un plazo de diez horas al juez competente y al Órgano de Revisión. El juez dispone de plazos estrictos para evaluar la medida, garantizándose al usuario el derecho a contar con un abogado defensor —público y gratuito si no designa uno privado— facultado para oponerse a la medida y solicitar la externación en cualquier momento. El alta, la externación o los permisos de salida son facultad exclusiva del equipo interdisciplinario de salud, sin que se requiera autorización judicial previa.

Para velar por el cumplimiento irrestricto de las garantías individuales y prevenir tratos indignos o inhumanos, la ley crea el Órgano de Revisión en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. Este organismo multidisciplinario e intersectorial está compuesto por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Defensa, asociaciones de usuarios y familiares, organizaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. El Órgano de Revisión posee facultades para ingresar e inspeccionar sin aviso previo cualquier

establecimiento de salud público o privado, mantener entrevistas privadas con las personas internadas, auditar historias clínicas, controlar la justificación de las internaciones involuntarias y las derivaciones fuera de la comunidad, así como requerir intervenciones judiciales o denunciar irregularidades. En suma, la Ley 26.657 y su Decreto Reglamentario 603/2013 estructuran un sistema tutelar de la salud mental que desplaza el modelo tutelar judicial-asilar para colocar en el centro de la práctica clínica e institucional la autonomía, la dignidad y la capacidad plena del usuario como sujeto de derecho.

M2.07. Lewkowicz, I. "Singularidades codificadas".

En su texto *Singularidades codificadas*, Ignacio Lewkowicz disuelve la aparente contradicción entre las categorías éticas formales —que definen la ética a través de la dialéctica entre lo Universal y lo Singular, relegando los códigos normativos al plano de la moral particular— y la transmisión de contenidos en los códigos de ética profesional. El autor demuestra que esta discrepancia surge de un modo inadecuado de concebir la codificación. En lugar de entender el código como un reglamento moral que totaliza de manera proactiva y necesaria todas las situaciones futuras bajo una ley cerrada, un código de ética debe conceptualizarse como un «cuerpo historial de singularidades decididas».

Bajo esta perspectiva, el texto normativo no es una dogmática prescriptiva que se aplica mecánicamente, sino una compilación fáctica de experiencias instituyentes del pasado en las que un principio vaciló ante un punto de inconsistencia y requirió una decisión en acto. Para explicar el funcionamiento interno de las normativas, Lewkowicz analiza la estructura de todo texto legislativo, compuesto por tres momentos: los *vistos* (el diagnóstico de una situación donde emerge una laguna o problema), los *considerandos* (el eje o valor simbólico desde el cual se intenta intervenir) y la *resolución* (la medida concreta arbitrada para modificar la situación).

La lectura ética de un código no se enfoca en el contenido prescriptivo de la resolución para exigir una obediencia ciega, sino que busca esclarecer los *considerandos* implícitos que sirvieron como norma vacía para orientar la práctica. De este modo, los códigos de ética descansan sobre prescripciones cuyo fundamento último es el despliegue y la suplementación simbólica, transmitiendo la experiencia de decisiones pasadas en lugar de imponer una moral absoluta. Lewkowicz establece una distinción fundamental entre dos formas de codificación y casuística. El «código moral» o constitucional opera mediante una totalización proactiva y estadística de los posibles, determinando de antemano lo que puede ocurrir y reservándose el derecho de admisión para mantener un sistema clausurado. Por el contrario, el «cuerpo historial» de la codificación fáctica funciona como un sistema abierto (*Codex*) que registra retroactivamente aquellas situaciones problemáticas donde los principios fueron puestos en cuestión e interpretados. Este cuerpo historial posee una *apertura esencial*: aunque simula estar cerrado porque no señala de antemano dónde se ubican sus fallas, la irrupción de una situación singular radicalmente imprevisible e in formulable abre el código. Al tomarse una nueva decisión ante la inconsistencia, esta opera mediante *suplementación*, transformando no solo la laguna específica sino el continente mismo que produjo esa omisión.

Para ilustrar la diferencia entre la rigidez normativa y la dinámica clínica, el autor recurre a una analogía con la historia del derecho ateniense del Siglo V a.C. Durante el periodo de Pericles (antes del 404 a.C.), la Asamblea de ciudadanos (*demos*) ejercía una soberanía absoluta e indeterminada: cualquier propuesta podía ser discutida y votada en acto sin estar sujeta a un techo constitucional previo. Sin embargo, tras la codificación del año 404 a.C., la soberanía se desplazó del *demos* a la ley escrita, instaurándose el procedimiento jurídico de la *graphé paranomon* para juzgar a quien propusiera medidas anticonstitucionales. Trasladando esta transformación al ámbito profesional, Lewkowicz contrapone la «soberanía del código jurídico» (donde la ley limita y clausura el devenir) con la «soberanía de la práctica clínica» (donde la decisión en acto mantiene su potencia instituyente sobre la norma dada).

Finalmente, el texto redefine el concepto de tradición y las prácticas de transmisión. Superando los esquemas lineales de pura continuidad o mera ruptura, Lewkowicz concibe la tradición como un legado de singularidades decididas que proporciona un cuerpo de conocimientos previos. Este saber heredado no funciona como una prescripción *a priori* completa que exige obediencia, sino como un «recurso para pensar» que ofrece condiciones para intervenir ante los problemas inéditos del presente. En última instancia, que un código opere como un dogma cerrado o como un registro abierto depende de las prácticas materiales de lectura, interpretación y transmisión; transmitir un código de ética significa transmitir en acto una modalidad práctica de relación entre el texto escrito y las circunstancias clínicas cambiantes.

M2.04. Freud, S. "Puntualizaciones sobre el amor de transferencia".

En las *Puntualizaciones sobre el amor de transferencia* (1915 [1914]), Sigmund Freud aborda uno de los desafíos técnicos y éticos más complejos del tratamiento psicoanalítico: la irrupción de un enamoramiento apasionado por parte de la paciente hacia la figura del analista. Lejos de concebir este fenómeno como un obstáculo accidental o como un triunfo personal atribuible a los atractivos del médico, Freud establece que el «amor de transferencia» es una manifestación inevitable y estructuralmente provocada por el propio encuadre clínico. Mientras que para el profesional principiante esta situación puede representar una crisis abrumadora que amenaza con suspender la terapia, para el psicoanálisis constituye una herramienta clínica decisiva que, adecuadamente dirigida, permite acceder a los fundamentos psíquicos más profundos del padecimiento neurótico.

Freud revela la naturaleza paradójica de este enamoramiento al señalar su estrecha vinculación con la *resistencia*, entendida como el mecanismo de defensa inconsciente que se opone a la labor analítica. La demanda apasionada de amor surge con especial intensidad en el momento preciso en que el tratamiento se aproxima a fragmentos biográficos dolorosos y fuertemente reprimidos. En ese punto, la paciente abandona la cooperación intelectual y el interés por las explicaciones analíticas, sustituyendo la tarea de recordar por la exigencia de una satisfacción afectiva inmediata. Se despliega así la compulsión a la repetición, donde el sujeto intenta actuar (*agieren*) en la realidad presente lo que únicamente debiera reproducirse y elaborarse en la memoria como material psíquico. De este modo, la resistencia instrumentaliza la inclinación afectiva para inhibir el avance de la cura y desorientar al analista.

A pesar de este uso defensivo, Freud cuestiona si es legítimo dudar de la autenticidad de dicho sentimiento y concluye que no hay razones para negarle el carácter de amor «genuino». Al igual que cualquier enamoramiento en la vida cotidiana fuera del análisis, el amor de transferencia está compuesto por la reedición de modelos infantiles y la repetición de fijaciones afectivas primarias. Su naturaleza compulsiva y su desatención a la realidad objetiva no son más que rasgos exacerbados que caracterizan a toda pasión amorosa. Sin embargo, el amor de transferencia se singulariza por tres propiedades específicas: es provocado por la situación analítica, es intensificado por la resistencia y muestra un acusado desinterés por el principio de realidad.

La respuesta técnica frente a esta encrucijada se fundamenta en la *regla de abstinencia*. Freud rechaza de manera categórica dos errores opuestos: ceder a los requerimientos amorosos de la paciente o sofocar autoritariamente sus impulsos mediante discursos moralizantes. Corresponder al afecto resultaría destructivo

para el tratamiento, pues significaría la victoria de la neurosis y el sometimiento de la cura a la compulsión a la repetición, imposibilitando toda rectificación psíquica. Por otro lado, exigir la sofocación inmediata del deseo equivale a conjurar un fantasma reprimido para volver a sepultarlo presa del terror, provocando solo el desaire y la venganza de la paciente. La posición del analista debe ceñirse a la denegación: se debe permitir que la necesidad y la añoranza subsistan como las fuerzas pulsionales imprescindibles para el trabajo de transformación, evitando apaciguarlas mediante satisfacciones sustitutivas.

Para sostener esta posición, el analista debe ejercer un riguroso dominio sobre la *contratransferencia*, concepto que designa las reacciones afectivas inconscientes que la conducta de la paciente suscita en el propio terapeuta. El médico no debe atribuir el enamoramiento a sus virtudes personales ni ceder a la tentación de gratificar su propio narcisismo. El encuadre analítico exige una veracidad absoluta y una neutralidad científica que evite tanto la mentira pedagógica como la frialdad distante. Al tratar el amor de transferencia como algo irreal en el plano de la acción fáctica, pero absolutamente real en el plano psíquico, se construye un espacio seguro para que la paciente saque a la luz las condiciones infantiles de su vida amorosa, sus fantasías inconscientes y las bases de su elección de objeto.

En conclusión, el manejo del amor de transferencia exige al psicoanalista librar una triple lucha: en su interior, contra las tentaciones contratransferenciales; fuera del análisis, contra las objeciones de la sociedad que teme el manejo de las fuerzas sexuales; y en la clínica, contra las exigencias pulsionales de los pacientes. Comparando la práctica psicoanalítica con la química, Freud argumenta que, aunque se trabaje con elementos altamente explosivos, la peligrosidad de la materia no justifica abandonar las herramientas terapéuticas eficaces. Sostener la transferencia amorosa en estado de abstinencia permite que la paciente venza el principio de placer y adquiera aquel plus de libertad psíquica necesario para disponer de su capacidad de amar en la vida real.

M2.08. **Salomone, G.** "El principio de neutralidad y la regla de abstinencia: la perspectiva freudiana".

El escrito de Gabriela Z. Salomone aborda la delimitación conceptual y la articulación clínica entre la Regla de Abstinencia y el Principio de Neutralidad en las recomendaciones técnicas de Sigmund Freud. La autora aclara que, aunque habitualmente se utilizan como términos equivalentes, representan dos tipos de indicaciones bien diferenciadas que se dirigen a agentes distintos de la cura: la Regla de Abstinencia se enfoca en las dinámicas de satisfacción pulsional del paciente, mientras que el Principio de Neutralidad constituye la abstinencia impuesta a la persona del analista en tanto agente de la función.

La Regla de Abstinencia establece como fundamento de la cura que el tratamiento psicoanalítico debe ejecutarse en estado de privación o frustración (*Versagung*). Denegar las satisfacciones sustitutivas persigue tres objetivos clínicos centrales: mantener subsistentes la necesidad y la añoranza del paciente como fuerzas pulsionantes que sostienen el trabajo analítico; volver actuales y manifiestos los conflictos pulsionales latentes dentro del campo de la transferencia —bajo el principio freudiano de que nadie puede ser ajusticiado en ausencia—; y lograr el propósito analítico de retener los impulsos en el ámbito psíquico mediante el recuerdo y la reelaboración, evitando que la pulsión descargue a través de la acción o de la repetición en la vida real. Esta regla rige tanto para las satisfacciones que se intentan dentro de la cura (como la demanda de amor de transferencia o los reclamos de intimidad y preferencia) como para las satisfacciones sustitutivas fuera de ella en la vida cotidiana del paciente.

Por su parte, el Principio de Neutralidad impone una exigencia de abstinencia para el propio analista, obligándolo a sustraer de la escena clínica sus expectativas conscientes, sus ideales personales, sus valores morales, sus sentimientos contratransferenciales y sus concepciones filosóficas del mundo (*Cosmovisión*). Freud advierte que imponer al paciente los propios ideales para moldearlo a imagen y semejanza del analista constituye un acto de violencia, por más nobles que parezcan las intenciones. La neutralidad exige desestimar tanto la "ambición terapéutica" —el afán desmedido de sofocar síntomas velozmente mediante el uso de la autoridad o la sugestión— como la "ambición pedagógica" —la inclinación a educar, aconsejar o dirigir la vida del analizado—. El analista debe funcionar como la luna de un espejo, devolviendo únicamente lo que le es mostrado, para que el paciente pueda tomar sus decisiones de manera autónoma y liberar su propio ser.

Asimismo, Salomone demuestra que el Principio de Neutralidad es la condición de posibilidad para alcanzar la Atención Flotante, la cual consiste en prestar una atención libremente fluctuante a todo cuanto se escucha, sin fijarse ni seleccionar

fragmentos en función de las expectativas previas del terapeuta. Esta técnica de escucha, correlato de la regla de asociación libre del paciente, solo puede sostenerse cuando el analista vence la tentación de dirigir el material y se abstiene de intervenir como persona.

La articulación entre ambos principios revela su íntima dependencia clínica: la neutralidad del analista es la condición necesaria para poder aplicar la Regla de Abstinencia sobre el paciente. Al sustraerse como persona, el analista evita la tentación de ofrecer su propio yo como un objeto de satisfacción sustitutiva, impidiendo la concreción de un pacto narcisista en la dimensión imaginaria y especular. Esta dinámica se ilustra en el célebre análisis del Caso Dora: cuando Freud inicialmente tomó partido por su paciente dándole la razón sobre la conducta de su padre, su neutralidad se vio comprometida y el análisis se estancó en la complicidad. Fue recién al reubicarse en la posición de neutralidad cuando Freud pudo ir más allá de la verdad objetiva de los hechos e implicar a Dora en su propia posición subjetiva mediante la histórica pregunta sobre qué parte le tocaba a ella en el mal del que se quejaba, produciendo una primera inversión dialéctica que reorientó el curso de la cura.

M2.09. **Laso.** "Un método peligroso. La transferencia amorosa, un siglo después".

El escrito elaborado por Juan Jorge Michel Fariña, Eduardo Laso y colaboradores aborda el estatuto clínico y ético del amor de transferencia, tomando como punto de partida la reconstrucción histórica del secreto Romance que mantuvo Carl Jung con su joven paciente Sabina Spielrein, retratado en el film *A Dangerous Method* de David Cronenberg. El texto expone cómo la irrupción del amor de transferencia — fenómeno descubierto precozmente por Josef Breuer en el caso Anna O. y experimentado por múltiples pioneros del psicoanálisis— generó de forma sistemática reacciones de huida aterrorizada o de involucración erótica directa, ambas destructivas para la dirección de la cura. La resolución teórica de este problema fue formulada por Sigmund Freud en mil novecientos quince en su escrito "Puntualizaciones sobre el amor de transferencia", obra visionaria que deslindó definitivamente los imperativos de la moral victoriana de las verdaderas exigencias de la ética analítica.

Los autores destacan que la prohibición de mantener relaciones sexuales o sentimentales con pacientes y ex-pacientes —consagrada posteriormente por los códigos deontológicos de la *American Psychological Association* (APA) y por las normativas profesionales locales— no responde al decoro social ni a la prudencia moral. La verdadera razón de esta proscripción se fundamenta en la asimetría estructural de la situación psicoterapéutica: el analista ocupa un lugar de poder en tanto aloja la demanda y encarna la función transferencial. Aprovechar esa posición para satisfacer los propios deseos eróticos o afectivos constituye un abuso de poder que degrada el tratamiento a un pacto narcisista, cancelando la posibilidad de que el paciente elabore su conflicto y reduciendo la práctica a una forma de goce a expensas del analizado.

Para fundamentar la necesidad innegociable de la abstinencia, Eduardo Laso analiza las cuatro metáforas principales que Freud despliega en su texto de mil novecientos quince. La primera metáfora es la de la escena teatral suspendida: Freud explica que el amor erótico de transferencia irrumpe masivamente como una manifestación de la resistencia cuando el análisis se aproxima al núcleo patógeno del síntoma. Esta emergencia equivale al grito de "fuego" en mitad de una representación teatral, irrumpiendo un Real pulsional ardiente que destruye el juego de palabras e imágenes de la sesión. La segunda metáfora es la del conjurador de espíritus subterráneos: Freud ridiculiza al analista que adopta una postura moralista intentando exhortar al paciente a la renuncia pulsional, comparándolo con un brujo cobarde que utiliza ingeniosos conjuros para invocar a un espíritu y luego huye aterrorizado sin interrogarlo cuando el fantasma se hace presente. La posición del analista requiere el valor de soportar la repetición en

transferencia para introducirla en el campo de la palabra, o como diría Jacques Lacan, para "hacer entrar al caballo en el picadero".

La tercera metáfora se ilustra con el cuento del pastor y el agente de seguros: Freud desmiente que corresponder al amor del paciente sea un medio eficaz para asegurar la influencia terapéutica y alcanzar la curación. Esta ilusión equivale a la historia del pastor que visita a un vendedor de seguros ateo en su lecho de muerte para convertirlo a la fe; tras horas de discusión, el asegurador no se convierte, pero el pastor sale del recinto habiendo contratado una póliza de vida. El analista que intenta curar mediante la correspondencia amorosa termina siendo capturado por el discurso y el goce del paciente. Finalmente, la cuarta metáfora es la del chistoso y la carrera de perros: Freud compara al analista que satisface sus propios deseos eróticos en la cura con un pícaro que arroja una salchicha en mitad de una pista de carreras. Los perros se abalanzan sobre el alimento inmediato, olvidando la competencia y la verdadera recompensa que aguardaba al final. El sexo del analista ofrecido como satisfacción sustitutiva degrada la función analítica a un mero órgano físico, interrumpiendo el tratamiento y privando al paciente de alcanzar la verdadera meta del análisis, la cual consiste en recuperar la capacidad de amar y trabajar en la vida real. El texto concluye enfatizando que la caída del lugar del analista por involucramiento sexual es un punto de no retorno, pues el paciente puede tolerar los errores de interpretación de su terapeuta, pero jamás que este deserte de su posición ética.

M2.10. Ormart, E. "Factores a ponderar en las relaciones amorosas entre terapeutas y ex pacientes en la clínica psicológica".

El artículo elaborado por Elizabeth B. Ormart investiga los límites éticos y las representaciones profesionales en torno a las relaciones amorosas entre terapeutas y sus pacientes o ex-pacientes. La autora parte de constatar un contraste inicial: mientras que el involucramiento sexual con un paciente en tratamiento es universalmente rechazado por la comunidad científica como una falta grave y una mala praxis, la posibilidad de iniciar un vínculo afectivo con un ex-paciente constituye un terreno ambiguo, polarizado por intuiciones morales y caracterizado por un vacío deontológico en la legislación argentina. Para abordar esta problemática, Ormart propone articular la deontología profesional —entendida como la "ética de mínimos" consensuada por los códigos normativos— con la clínica del inconsciente desarrollada por el psicoanálisis, reconociendo que ambas dimensiones son irreductibles entre sí pero deben ponerse en diálogo.

La metodología del estudio se basó en una encuesta aplicada a trescientos cuatro psicoterapeutas (psicólogos y médicos psiquiatras) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expuestos a situaciones dilemáticas. Ante la primera situación —la atracción mutua con un paciente en tratamiento—, la inmensa mayoría de los encuestados (92,8%) se manifestó a favor de interrumpir la terapia, proponiendo un 29% la derivación a otro profesional para dar inicio al romance. La autora realiza una crítica profunda a esta respuesta mayoritaria, demostrando que refleja una concepción moralista que desconoce la técnica freudiana. Desde la perspectiva psicoanalítica, suspender el tratamiento o derivar a la paciente para perseguir una atracción personal constituye un acto no ético donde el terapeuta prioriza su propio beneficio por sobre la salud del consultante. La mera interrupción del contrato formal no disuelve el amor de transferencia, el cual no es un fenómeno coyuntural sino la actualización de fijaciones infantiles y edípicas en el escenario clínico. Interrumpir la terapia ante la irrupción de la atracción destruye el proceso analítico y transforma a la paciente en una amante despechada, mientras que la verdadera regla de oro de la técnica consiste en sostener la abstinencia y utilizar esa transferencia amorosa insatisfactoria como el motor de la cura.

Para analizar la segunda situación —el inicio de un vínculo amoroso con un ex-paciente—, el trabajo toma como marco de referencia la Norma 4.07 del Código de la American Psychological Association (APA). Este código establece un plazo mínimo de dos años de moratoria tras la finalización del tratamiento y exige al profesional demostrar de manera fehaciente que no ha sacado provecho de la situación, ponderando siete factores clave: el tiempo transcurrido, la naturaleza y duración de la terapia, las circunstancias de la finalización (evaluando si se

interrumpió el análisis con la intención oculta de iniciar el noviazgo), la historia personal del paciente, su estado mental actual, la probabilidad de un impacto negativo sobre él o terceros, y cualquier insinuación o sugerencia promovida por el terapeuta durante las sesiones respecto de una relación futura.

Al evaluar las respuestas de los terapeutas porteños frente a los ex-pacientes, se observa que el tiempo es la variable más citada (8%), prevaleciendo la idea de que tras el paso de un lapso "prudencial" la relación queda habilitada. Ormart advierte que esta postura incurre en el error de reducir el vínculo terapéutico a un mero contrato comercial de prestación de servicios que expira con el alta formal. Esta perspectiva desconoce el principio psicoanalítico fundamental de la atemporalidad del inconsciente, según el cual los residuos transferenciales, la desidealización incompleta y la asimetría de poder persisten en el psiquismo mucho tiempo después de finalizadas las sesiones. Para fundamentar este límite, la autora establece una analogía directa con el secreto profesional: si la obligación deontológica de guardar confidencialidad no cesa cuando concluye la relación psicólogo-cliente, las responsabilidades éticas derivadas del vínculo transferencial tampoco pueden considerarse extinguidas por el solo hecho de firmar el alta médica, exigiendo al profesional una permanente reflexión que anteponga el cuidado del paciente a sus propios intereses.

M2.15. Gutiérrez, Salomone. “El abuso contra los niños. Responsabilidad, legislación y principios éticos”.

El análisis de la práctica psicológica ante situaciones de violencia y abuso contra menores exige interrogar de manera crítica las relaciones entre la ley social, las normativas deontológicas y los principios éticos. Los autores sostienen que las leyes positivas y los códigos deontológicos —entendidos estos últimos como los reglamentos normativos consensuados por una comunidad profesional en una época específica— se encuentran atravesados por los valores morales y los intereses propios de un momento histórico determinado. Debido a este anclaje epocal, tales ordenamientos normativos no siempre resultan concordantes con la singularidad subjetiva, esto es, con la consideración irremplazable de la dimensión psíquica de cada individuo concreto. Por ello, el horizonte orientador de la labor clínica no puede reducirse al acatamiento legalista o corporativo, sino que debe fundarse en los principios éticos, cuyo mandato primordial es el resguardo incondicional de la subjetividad frente a cualquier reducción estandarizada que devalúe lo humano.

Esta tensión conceptual cobra especial relieve frente al dilema de sostener o levantar el secreto profesional en circunstancias extremas, como en los casos de abuso o violencia intrafamiliar hacia menores. El examen de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar (Ley Nacional 24.417) revela en su artículo segundo un mandato explícito que obliga a los profesionales asistenciales y de la salud a denunciar tales hechos. No obstante, su decreto reglamentario (Decreto 235/96) introduce un elemento decisivo: si bien estipula un plazo máximo de 72 horas para formular la denuncia, habilita de manera expresa la extensión de dicho plazo por motivos fundados a criterio del profesional actuante. Esta elasticidad normativa no introduce una mera ambigüedad formal, sino que abre un espacio indispensable para el acto clínico. Los autores destacan que la Ley 24.417 fue concebida en el fuero civil expresamente para superar las limitaciones del fuero penal. Mientras que la intervención penal opera de manera unidireccional y exclusivamente punitiva —lo que en términos psicoanalíticos equivaldría a una simple supresión del síntoma mediante el encarcelamiento del agresor sin resolver la trama conflictiva familiar subyacente—, el fuero civil inaugura un abordaje integral mediante dispositivos asistenciales, tratamientos de salud mental o medidas de exclusión del hogar, articulando a la ley social en su función de regulador simbólico dentro de la cultura.

Al conceder un margen de tiempo fundado en el criterio del terapeuta previo a la radicación de la denuncia, la legislación civil admite que una intervención psicológica oportuna logre desactivar o controlar la situación de riesgo; de consumarse ese éxito terapéutico, el hecho lesivo desaparecería, tornando la

denuncia judicial en un acto sobreabundante o innecesario. Es en esta encrucijada donde se despliega en toda su magnitud la responsabilidad profesional, entendida como la posición de un terapeuta que se encuentra en absoluta soledad en su acto y desprovisto de garantías predeterminadas. Frente a la disyuntiva, el psicólogo debe esquivar dos conductas igualmente fallidas y punibles: por un lado, la postergación negligente, que dilata indebidamente la intervención y expone a la víctima a un agravamiento del daño; por el otro, la denuncia precipitada, producto de una obediencia maquinal a la letra de la ley que utiliza el mandato burocrático como refugio para eludir la implicación clínica. En este último extremo, el profesional renuncia a su función específica y se degrada a la condición de un mero funcionario administrativo o informante estatal.

Para orientar este acto en soledad, el criterio clínico debe diferenciarse tajantemente de la moral subjetiva del terapeuta y subordinarse al concepto freudiano de neutralidad. Lejos de la interpretación de sentido común que equipara de manera simplista la neutralidad con el silencio obstinado del secreto profesional, los autores postulan que ser neutral exige desalojar activamente la dimensión narcisista de los ideales —ya se trate de los valores personales del terapeuta, de los ideales del paciente o de los mandatos de la sociedad— para atender exclusivamente a la dimensión del sujeto del inconsciente. De este modo, el secreto profesional deja de ser un fetiche inviolable o un dogma apriorístico y se transforma en una variable técnica del tratamiento que debe ponerse al servicio de la neutralidad y evaluarse según las coordenadas particulares del caso.

La aplicación de este marco analítico demanda un abordaje diferencial ante la singularidad de los cuadros clínicos. En el caso de un padre agresor, la viabilidad de una operación terapéutica dirigida a cesar las conductas violentas puede justificar clínicamente la postergación transitoria de la denuncia judicial para tramitar el conflicto en el espacio analítico. Por el contrario, frente a la atención de un niño víctima de apropiación ilegal de identidad, carece de todo fundamento ético y técnico demorar la presentación judicial bajo el argumento de preparar psíquicamente al menor; en dicha coyuntura, la postergación constituye una ilusión teórica mientras el delito de sustracción de identidad permanece flagrante y activo. A su vez, el escenario de una niña víctima de abuso sexual o violación — particularmente en el ámbito intrafamiliar— presenta una gravedad distintiva: el cese empírico del abuso no elimina el daño, dado que el hecho desencadena un desorden simbólico severo en la estructuración psíquica de la víctima.

En situaciones de esta índole, la labor estrictamente intrapsíquica en el consultorio resulta insuficiente si no convoca a un operador externo en función del "Otro de la Ley", es decir, a una instancia institucional que encarne el límite simbólico y la sanción social indispensable frente a la transgresión cometida. La denuncia

judicial, lejos de constituir un acto de delación policial ajeno a la psicología, deviene en la intervención clínica propiamente dicha, sin la cual la metabolización y tramitación psíquica del trauma no puede tener lugar. En conclusión, el mantenimiento o la suspensión del secreto profesional responde de manera indeclinable a la posición de neutralidad: cuando guardar silencio encubre un ideal perjudicial o bloquea la tramitación del daño, el levantamiento del secreto mediante la apelación a la ley social es el único medio legítimo para restablecer el orden simbólico y salvaguardar la subjetividad del paciente.

M3.01. American Psychological Association. "Principios éticos de los psicólogos y código de conducta. (2010)".

Los *Principios Éticos de los Psicólogos y Código de Conducta* de la American Psychological Association (APA), incluyendo sus enmiendas aprobadas en 2010, constituyen un cuerpo normativo integral diseñado para regular el desempeño científico, educativo y profesional de la psicología. Aplicable a diversas áreas —tales como la práctica clínica, la investigación, la docencia, la evaluación diagnóstica, la consultoría organizacional y la actuación forense, ya sea de forma presencial o mediante transmisiones electrónicas—, el Código excluye expresamente la conducta puramente privada del profesional. Su estructura se organiza a partir de una dualidad fundamental: por un lado, el Preámbulo y cinco **Principios Generales** (Principio A: Beneficencia y no maleficencia; Principio B: Fidelidad y responsabilidad; Principio C: Integridad; Principio D: Justicia; y Principio E: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas) establecen metas de carácter aspiracional no sancionables, destinadas a inspirar los más elevados ideales de la profesión; por otro lado, las **Normas Éticas** (secciones 1 a 10) fijan reglas de conducta obligatorias cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, profesionales o legales.

La Sección 1 de las Normas Éticas se aboca a la resolución de cuestiones éticas, contemplando el mal uso del trabajo profesional, la resolución informal de faltas y la obligación de cooperar con los comités disciplinarios. Un eje central de esta sección reside en las Normas 1.02 y 1.03 (enmendadas en 2010), las cuales regulan los conflictos entre las responsabilidades éticas y las leyes, regulaciones u órdenes institucionales. Estas normas disponen que, ante una colisión entre el Código de Ética y una exigencia legal o gubernamental, el psicólogo debe visibilizar la naturaleza del conflicto y tomar medidas razonables para resolverlo en consonancia con los Principios Generales del Código. De manera categórica, la enmienda de 2010 establece la cláusula prohibitiva absoluta de que bajo ninguna circunstancia estas normas pueden ser utilizadas para justificar o defender violaciones a los Derechos Humanos fundamentales.

Las Secciones 2 y 3 regulan la competencia profesional y las relaciones humanas. La Sección 2 (Competencia) exige que los psicólogos presten servicios únicamente dentro de los límites de su formación, capacitación y experiencia supervisada, imponiendo la actualización científica permanente y la obligación de abstenerse de iniciar o continuar actividades laborales cuando adviertan que problemas personales o de salud física/mental puedan interferir en su desempeño competente. La Sección 3 (Relaciones Humanas) prohíbe la discriminación injusta y cualquier forma de acoso (sexual u otro), ordena tomar medidas razonables para

evitar o minimizar daños previsibles y prohíbe incurrir en *relaciones múltiples* potencialmente dañinas —definidas como el hecho de ejercer un rol profesional con una persona mientras se mantiene simultáneamente otro rol, una relación personal/financiera o la promesa de establecerla en el futuro— cuando tales vínculos puedan menoscabar la objetividad o generar riesgo de explotación. Asimismo, esta sección regula la obtención del *consentimiento informado*, garantizando que los usuarios reciban explicación clara sobre los servicios en un lenguaje comprensible.

Las Secciones 4, 5 y 6 ordenan el manejo de la información, la difusión pública y la gestión financiera. La Sección 4 (Privacidad y Confidencialidad) impone la obligación primordial de resguardar la información confidencial, discutiendo sus límites al inicio del servicio y restringiendo las revelaciones sin consentimiento a casos previstos por ley o para fines legítimos, tales como proteger al paciente o a terceros de eventuales daños. La Sección 5 (Publicidad y Declaraciones Públicas) prohíbe afirmaciones falsas o engañosas sobre títulos, honorarios o éxitos terapéuticos, así como la solicitud de testimonios a pacientes vulnerables. La Sección 6 (Registros y Honorarios) exige la documentación precisa, almacenamiento seguro y eliminación confidencial de datos científicos y profesionales, estableciendo acuerdos financieros transparentes y prohibiendo expresamente la retención de registros requeridos para un tratamiento de emergencia debido a la falta de pago de honorarios.

Finalmente, las Secciones 7 a 10 contienen regulaciones específicas para la docencia, investigación, evaluación y terapia. La Sección 7 (Educación y Capacitación) vela por la precisión en los programas académicos y prohíbe relaciones sexuales con estudiantes sobre quienes se ejerza autoridad evaluativa. La Sección 8 (Investigación y Publicación) exige autorización institucional, consentimiento informado, protección de participantes subordinados, pautas estrictas para el uso justificado del engaño, *debriefing* (explicación posterior a los participantes), cuidado ético de animales de laboratorio y reconocimiento preciso de la autoría científica evitando el plagio. La Sección 9 (Evaluación) fundamenta el uso de tests psicométricos en evidencias de validez y confiabilidad, garantizando la interpretación adecuada de los datos y la seguridad de los materiales reactivos. La Sección 10 (Terapia) regula el encuadre clínico, disponiendo la obtención del consentimiento informado desde el inicio del tratamiento, la aclaración de roles en abordajes familiares o grupales y la prohibición absoluta de intimidad sexual con pacientes actuales (Norma 10.05), allegados (Norma 10.06), expartenaires (Norma 10.07) y expacientes (Norma 10.08, sujeta a un lapso mínimo de dos años e imposibilidad de demostración de no-explotación). A través de este conjunto sistemático de principios y reglas, el Código de Ética de la APA garantiza que la

American Psychological Association. "Principios éticos de los psicólogos y código de conducta. (2010)".

práctica psicológica responda de manera constante a la competencia científica, la responsabilidad social y la protección irrestricta de la dignidad humana.

M3.02. Asociación de psicólogos de Buenos Aires. “Código de ética”.

El *Código de Ética de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires* (APBA) constituye el marco axiológico y normativo destinado a regular el ejercicio profesional, científico y docente de la psicología dentro de su jurisdicción. Elaborado a partir de antecedentes nacionales e internacionales —tales como el Código de Ética de la APA de 1992, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y acuerdos deontológicos del Mercosur—, el texto se alinea explícitamente con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Aplicable de manera exclusiva a las actividades científicas y profesionales de los psicólogos (excluyendo la conducta puramente privada), el Código organiza su arquitectura formal sobre un dualismo estructural: el Preámbulo y cinco **Principios Generales** (Principio A: Competencia; Principio B: Integridad; Principio C: Responsabilidad profesional y científica; Principio D: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas; y Principio E: Responsabilidad social) establecen metas de carácter aspiracional no sancionables para orientar el horizonte ético; en contraste, las **Normas Éticas** (organizadas en siete secciones) fijan reglas de conducta obligatorias cuyo incumplimiento acarrea sanciones disciplinarias que van desde la amonestación hasta la suspensión o expulsión de la institución.

La Sección 1 (Normas Generales) delimita las condiciones básicas del ejercicio profesional, estableciendo que si el Código fija un estándar ético más elevado que el exigido por la ley positiva, debe primar el cumplimiento de la norma ética más alta. Los profesionales están obligados a prestar servicios únicamente dentro de los límites de su competencia —sustentada en títulos universitarios, capacitación y experiencia acreditada—, manteniendo una actualización científica permanente y absteniéndose de utilizar métodos que no hayan sido debidamente experimentados y aprobados por centros universitarios o científicos del país. La norma prohíbe explícitamente prestar el nombre o firma a personas no tituladas que ejerzan ilegalmente la psicología. Asimismo, los profesionales deben estar alertas a sus propios problemas o conflictos personales, suspendiendo o limitando su actividad si advierten que su eficacia puede verse alterada. Para proteger a los consultantes contra la explotación o la pérdida de objetividad, se prohíbe el acoso sexual y el establecimiento de *relaciones múltiples* dañinas (vínculos duales de carácter personal, financiero o profesional con pacientes o sus allegados), exigiendo además transparencia en los acuerdos financieros y en la documentación del trabajo.

Las Secciones 2 (Evaluación o Intervención) y 4 (Terapia) regulan los requisitos técnicos y clínicos de la atención psicológica. Las evaluaciones, psicodiagnósticos e intervenciones solo pueden realizarse dentro de un rol profesional definido,

utilizando instrumentos psicométricos cuya validez, confiabilidad y estandarización hayan sido fehacientemente probadas. Se prohíbe el uso de tests obsoletos o la administración de pruebas por personas no calificadas, garantizando siempre la devolución de los resultados al consultante en un lenguaje comprensible. En el ámbito terapéutico, la Sección 4 exige discutir de manera preliminar el *encuadre* (naturaleza de la terapia, honorarios y confidencialidad) y obtener el *consentimiento informado* fehaciente, asegurando que el paciente posea capacidad legal, reciba información adecuada y ejercite su decisión libremente. En casos de terapia familiar o de pareja, se debe clarificar el rol del terapeuta y el uso de la información para evitar conflictos de interés. De manera categórica, se prohíbe la intimidad sexual con pacientes actuales (Norma 4.05) y la aceptación como pacientes de personas con las que se hayan tenido vínculos sexuales previos (Norma 4.06).

La Sección 5 (Secreto Profesional) consagra la confidencialidad como una obligación primordial destinada a resguardar los derechos a la privacidad, intimidad y autodeterminación de las personas, estableciendo que el deber de reserva subsiste indefinidamente, incluso tras la finalización del tratamiento o el fallecimiento del consultante. Sin embargo, la Norma 5.07 detalla los límites y excepciones legítimas en las que el psicólogo puede revelar información confidencial sin incurrir en violación del secreto. Estas excepciones se circunscriben estrictamente a: (1) proveer servicios profesionales necesarios; (2) realizar consultas profesionales preservando la identidad del paciente; (3) cobrar honorarios mediante acciones legales mínimas; (4) dar cumplimiento a comisiones o mandatos judiciales compulsivos; (5) informar a padres o tutores de menores de edad cuando sea imprescindible para su mejor tratamiento; (6) ejercer la legítima defensa ante una acusación criminal formulada por el propio consultante; (7) evitar la comisión de un delito o mitigar sus daños derivados; y (8) evitar un daño grave e inminente para la vida o integridad física del propio consultante o de terceros.

Finalmente, las Secciones 6 (Docencia, Supervisión, Investigación y Publicación) y 7 (Resolución de Asuntos Éticos) ordenan la actividad académica y el juzgamiento disciplinario. La Sección 6 prohíbe el plagio y la fabricación de datos, exigiendo el consentimiento informado explícito para participantes en investigaciones (incluidas grabaciones) y el resguardo de la confidencialidad en publicaciones y docencia. La Sección 7 establece que el desconocimiento o la mala comprensión de una norma ética no justifica la conducta falta de ética, imponiendo el deber de colaborar con las investigaciones del Tribunal de Ética y Disciplina de la APBA. A través de este cuerpo integral, el Código de Ética de la APBA garantiza que la práctica de la psicología responda a criterios de rigor científico, responsabilidad social y protección irrestricta de los derechos humanos.

M4.05. **Laso, E.** "Las coordenadas de la obediencia. Milgram a través de la lectura de Zygmunt Bauman".

En su ensayo *Las coordenadas de la obediencia. Milgram a través de la lectura de Zygmunt Bauman*, Eduardo Laso examina los mecanismos sociales y estructurales de la obediencia a autoridades destructivas articulando el clásico experimento psicológico de Stanley Milgram con las reflexiones sociológicas del libro *Modernidad y Holocausto* de Zygmunt Bauman. Laso contrapone la lectura de Bauman con la tesis desarrollada por Theodor Adorno en *La personalidad autoritaria*, la cual atribuía las atrocidades del nazismo a una concentración atípica de individuos patológicos e intrínsecamente crueles. Bauman rechaza este reduccionismo psicológico, demostrando que el Holocausto no fue un brote irracional de sadismo individual, sino una consecuencia directa de la ingeniería social, la racionalización y la eficiencia técnica de la modernidad. La inhumanidad es un producto social: a medida que las relaciones humanas se burocratizan y fragmentan, la capacidad para producir crueldad se perfecciona. Las investigaciones de Milgram confirman empíricamente la postura de Bauman al probar que los actos aberrantes no son cometidos por monstruos, sino por sujetos comunes y corrientes que intentan cumplir eficientemente con las tareas asignadas dentro de estructuras normales de autoridad.

Laso detalla los cinco factores vinculantes (*factores vinculantes*) identificados por Bauman en el diseño de Milgram que facilitan la sumisión de una persona común ante órdenes destructivas. El primer factor es la *distancia social*, la cual separa físicamente al sujeto que aplica las descargas («maestro») de la víctima que las recibe («alumno»). Retomando la ética del filósofo Emmanuel Lévinas sobre la responsabilidad que impone la mirada del otro, Laso señala que ubicar a la víctima en una habitación contigua ahorra al perpetrador la confrontación directa con el «rostro de la víctima», disminuyendo la percepción del dolor causado. La sociedad moderna opera mediante una fragmentación similar de la acción, interponiendo eslabones intermedios que alejan al individuo del resultado destructivo final. Además, esta separación física genera una incipiente *estructura de masa*: une al maestro y al experimentador en un sentimiento de pertenencia a una tarea común, mientras aísla a la víctima como un objeto segregado.

El segundo factor es la *paradoja de la acción secuencial*, un procedimiento gradual que incrementa las descargas eléctricas en pequeños tramos de 15 voltios. Esta secuencia repetitiva atrapa al sujeto en una trampa moral: negarse a aplicar un determinado nivel de voltaje por considerarlo dañino implica admitir implícitamente que la descarga anterior, apenas ligeramente menor, también era incorrecta. Para no descalificar sus propios actos pasados ni comprometer su

autoimagen moral, el sujeto se ve impulsado a continuar, quedando atrapado en una escalada de compromiso mucho después de haber perdido interés en los fines del experimento. El tercer factor es la *moralización de la tecnología*, propia de los sistemas burocráticos. En ella, la conciencia moral del sujeto deja de evaluar la bondad o maldad del resultado final (el sufrimiento de la víctima) para centrarse exclusivamente en la eficiencia técnica, la disciplina, la lealtad y el perfeccionamiento de la tarea. La moralidad subjetiva es sustituida por una «moralidad tecnológica», donde el individuo siente orgullo o vergüenza no por el impacto humano de su acción, sino por lo bien o mal que funciona como pieza dentro del sistema.

El cuarto factor es la *responsabilidad flotante*, habilitada cuando el sujeto entra en un *estado de agente*, es decir, cuando cede su autonomía y se percibe a sí mismo como un mero instrumento que ejecuta la voluntad de un tercero. En organizaciones burocráticas complejas, este mecanismo produce una disolución generalizada de la responsabilidad donde todos los miembros están convencidos de estar cumpliendo órdenes de una «autoridad competente superior». Laso enfatiza que la responsabilidad flotante jamás puede funcionar como una excusa o atenua para eximir de culpa a los perpetradores; por el contrario, constituye un *agravante ético*, ya que la estructura institucional misma ha sido configurada previamente para borrar la responsabilidad individual antes de la ejecución del acto.

El quinto factor es la *concentración del poder*. Milgram demostró que la respuesta de obediencia ciega exige una fuente de autoridad única, monopolística e inequívoca. Para comprobar esta variable, Milgram introdujo una variante en su experimento donde dos experimentadores escenificaban un desacuerdo en presencia del sujeto. El resultado fue contundente: el 90% de los participantes se negó a continuar ante la primera señal de discrepancia entre las autoridades. Este hallazgo prueba que la sumisión a órdenes destructivas no depende solo del mandato autoritario, sino de la ausencia de voces disidentes. Las dictaduras, sectas y regímenes totalitarios fomentan la obediencia ciega erradicando la divergencia y consagrando un discurso único. Laso concluye reafirmado que el pluralismo social e institucional —la existencia de fuentes de autoridad contrapuestas y compensatorias— constituye la herramienta preventiva más eficaz para impedir que personas moralmente normales participen en acciones inhumanas.

M2.09. Michel Fariña, J.J. “De la eugenesia a los crímenes nazis”.

En su texto *De la eugenesia a los crímenes nazis*, Juan Jorge Michel Fariña rastrea los orígenes históricos y conceptuales que hicieron posible las atrocidades médicas del siglo XX, comenzando por la transición del feudalismo al capitalismo industrial. La sustitución de la tierra por la máquina como medio de producción hegemónico provocó la caída del pensamiento metafísico e inauguró un protagonismo creciente de la razón técnica. Esta concepción mecanicista de la naturaleza fue prefigurada en 1543 por el anatomista André Vésale en *La fábrica del cuerpo humano*, donde anticipaba el dominio científico sobre el organismo. Durante el siglo XIX, la fisiología consolidó el método experimental de la mano de Claude Bernard, quien introdujo categorías como la vivisección y la noción de «sujeto experimental». Bernard planteó de manera explícita la permisibilidad de realizar experiencias biológicas sobre seres humanos desahuciados o condenados a muerte, argumentando que, al estar destinados a morir, sus cuerpos podían ser utilizados para el progreso científico. Esta lógica desplazó el principio ético tradicional del juramento hipocrático, *primum non nocere* (lo primero es no hacer daño), sustituyéndolo por un cálculo utilitarista que sopesaba los sufrimientos individuales frente a los hipotéticos beneficios que la acción médica pudiera aportar a la humanidad.

A comienzos del siglo XX, la biología y la medicina alcanzaron una posición de hegemonía disciplinaria. La convergencia del darwinismo social y las teorías raciales dio origen al movimiento eugenésico, término propuesto en 1883 por el científico británico Francis Galton para definir la «ciencia del mejoramiento del linaje», orientada a dar a las razas mejor dotadas mayores probabilidades de prevalecer. La eugenesia se manifestó en dos vertientes: la *eugenesia positiva*, dedicada a estimular la reproducción de los sectores considerados superiores mediante incentivos sociales o fiscales; y la *eugenesia negativa*, enfocada en restringir la descendencia de las poblaciones clasificadas como «inferiores» o «anormales» mediante la esterilización forzada y la eutanasia. Estados Unidos fue pionero en la implementación de leyes eugenésicas negativas al promulgar en Indiana, en 1907, la esterilización obligatoria de criminales considerados peligrosos. El movimiento se extendió rápidamente a escala internacional, contando con el respaldo de destacados referentes científicos de la época, como los Premios Nobel franceses Alexis Carrel y Charles Richet, este último promotor explícito de la supresión de los anormales.

Aunque la eugenesia no nació en Alemania, encontró en ese país su desarrollo más radical. Durante la República de Weimar se implementaron créditos fiscales para familias «valiosas», esterilizaciones a personas «genéticamente inferiores» y

experimentos iniciales con seres humanos. Con la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, el régimen transformó la eugenesia en doctrina estatal, resumida en la premisa de Rudolf Hess de que el nazismo no era otra cosa que «biología aplicada». Proclamando la «raza nórdica» como ideal biológico, el régimen promulgó en julio de 1933 la *Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias*, redactada por abogados, médicos de salud pública y psiquiatras. Esta norma creó más de 200 tribunales eugenésicos facultados para ordenar la esterilización forzada de hombres y mujeres que padecieran alguna de las nueve afecciones consideradas hereditarias (retardo mental, esquizofrenia, trastorno bipolar, epilepsia, enfermedad de Huntington, ceguera y sordera genéticas, deformidad física grave y alcoholismo crónico), derivando en la esterilización compulsiva de aproximadamente 400.000 ciudadanos alemanes.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el Estado biológico nazi transitó de la prevención reproductiva al exterminio abierto. Como declaró Karl Brandt, médico personal de Hitler, el contexto bélico facilitaba la eliminación de los «incurables» al mitigar la resistencia de la opinión pública. Los programas de eutanasia estatal (como la Acción T4) se extendieron a enfermos psiquiátricos e incurables, y rápidamente esta maquinaria médica se aplicó a la población judía, categorizada por la antropología y medicina nazi como una «raza subhumana» (*Untermenschen*). El colectivo médico desempeñó un rol operativo fundamental en este proceso: profesionales de la salud participaron activamente en la selección de víctimas, el diseño de métodos de aniquilación por gas, la ejecución de experimentos cruentos en los campos de concentración y la gestión de la higiene racial, convirtiendo la profesión médica en un engranaje central de la solución final.

Para comprender cómo una sociedad altamente instruida aceptó y colaboró con semejantes atrocidades, Michel Fariña analiza las operaciones ideológicas de adoctrinamiento y fascinación de las masas por los ideales totalitarios. Utilizando el cine como herramienta hermenéutica, el autor cita obras como *Cabaret* de Bob Fosse para mostrar cómo la propaganda y la retórica del porvenir pueden seducir a una población devastada por la derrota económica, llevándola a comprometerse con causas destructivas. Asimismo, la representación cinematográfica de los médicos nazis en filmes como *El huevo de la serpiente* de Ingmar Bergman, *La decisión de Sophie* de Alan Pakula, *La vida es bella* de Roberto Benigni, *La caída* de Oliver Hirschbiegel y *QBVII* de Leon Uris permite poner al descubierto las distintas facetas del horror. Estas reconstrucciones estéticas demuestran que los crímenes médicos no fueron producto exclusivo del sadismo o la demencia individual, sino también de la prolijidad técnica, el delirio pseudocientífico y la silenciosa banalidad del mal, donde la autoridad médica despojó al ser humano de su condición de sujeto para reducirlo a un mero objeto de desecho biológico.

M3.05. **Ormart, E.** "Problemas éticos en la experimentación psicológica. Asch, Milgram y Zimbardo en cuestión".

El artículo elaborado por Elizabeth Ormart, Natacha Lima, Flavia Navés y Federico Pena examina la evolución de la dimensión ética en la experimentación psicológica desde la refundación positivista de la disciplina hasta la consolidación de la bioética contemporánea. La historia de la psicología experimental, iniciada formalmente con el laboratorio de Leipzig de Wilhelm Wundt en mil ochocientos setenta y nueve y profundizada por el conductismo de John B. Watson, se caracterizó inicialmente por la ausencia total de marcos regulatorios que protegieran a los sujetos de investigación. Esta falta de límites éticos se evidencia en el experimento del "Pequeño Albert" realizado por Watson y Rayner en mil novecientos veinte, donde se condicionó fóbicamente a un bebé de once meses mediante ruidos estruendosos para demostrar las leyes del aprendizaje asociativo, sin considerar la producción de daño psíquico, la ausencia de consentimiento materno ni la falta de reparación del trauma.

Esta concepción científicista sufrió un vuelco paradigmático tras la Segunda Guerra Mundial con los juicios a los médicos nazis y la posterior promulgación del Código de Núremberg en mil novecientos cuarenta y siete. Este documento estableció por primera vez diez principios universales para la investigación legítima en seres humanos, destacando la necesidad absoluta del consentimiento voluntario e informado, la evitabilidad del sufrimiento físico o mental innecesario, la libertad del participante para interrumpir la prueba y la estricta proporcionalidad entre los riesgos asumidos y la importancia humanitaria de los beneficios sociales esperados.

A diferencia del conductismo temprano, los experimentos de psicología social desarrollados entre mil novecientos cincuenta y mil novecientos setenta surgieron movizados por una preocupación ético-política legítima: comprender cómo los seres humanos comunes pueden ser permeables a la presión social, la autoridad y la deshumanización del otro. Sin embargo, el análisis detallado de los estudios conducidos por Solomon Asch, Stanley Milgram y Philip Zimbardo demuestra que en su ejecución práctica se quebrantaron sistemáticamente los principios de Núremberg y las normativas bioéticas posteriores.

En los experimentos de conformidad de Asch de mil novecientos cincuenta y uno, se evaluó cómo la presión de un grupo de cómplices que emitía respuestas falsas llevaba a los sujetos a modificar su juicio perceptivo evidente. Aunque no hubo daño físico, el estudio implicó el uso de consignas engañosas —ocultando el verdadero objetivo de medir la sumisión grupal— y generó un severo malestar psíquico al tensionar al participante entre su propia percepción y la tiranía de la

mayoría. En los experimentos de obediencia a la autoridad de Milgram de mil novecientos sesenta y uno, la gravedad se incrementó drásticamente: los participantes fueron engañados para que administraran descargas eléctricas supuestamente mortales (hasta cuatrocientos cincuenta voltios) a un desconocido que gritaba de dolor. Milgram sometió a los sujetos a un sufrimiento emocional y angustia extremos —llegando a registrar convulsiones en algunos casos— e interfirió activamente con la libertad de interrumpir la prueba mediante consignas imperativas en las que el investigador exigía continuar. Por su parte, la simulación de la Prisión de Stanford realizada por Zimbardo en mil novecientos setenta y uno representó el caso más extremo de degradación: la asignación aleatoria de roles entre estudiantes (guardias y prisioneros) derivó en sadismo, tratos deshumanizantes y privaciones físicas que destruyeron la autonomía y la integridad de los participantes, obligando a suspender el estudio al sexto día tras perder el propio investigador la neutralidad científica.

Al contrastar estas investigaciones con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de dos mil cinco y la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos de dos mil ocho, se constatan severas infracciones a los principios de dignidad, autonomía, minimización de efectos nocivos y transparencia. La utilización de consignas engañosas, la presencia de incentivos económicos que pueden sesgar la voluntad (como la paga en Zimbardo) y la falta de recaudos para reparar el daño infligido vulneran los estándares éticos modernos. Asimismo, estos experimentos ponen al descubierto el enorme poder de la transferencia otorgada a la ciencia: la presencia de la autoridad representada en la universidad prestigiosa o el guardapolvo blanco obnubila el juicio moral autónomo del participante, facilitando la ejecución de actos crueles bajo la coartada de obedecer órdenes o colaborar con la investigación.

En conclusión, los autores sostienen que el avance del conocimiento científico jamás puede situarse por encima del bienestar y la dignidad de las personas. La experiencia de Asch, Milgram y Zimbardo demuestra que la evaluación de la proporcionalidad entre daño y beneficio no puede quedar a criterio del sesgo narcisista del investigador. El gran desafío pedagógico para la psicología contemporánea consiste en formar profesionales con competencias éticas reales, capaces de ejercer la investigación sin caer en la seducción del mercado ni reducir el consentimiento informado a un trámite burocrático formal, garantizando en todo momento el respeto irrestricto por la subjetividad y los derechos humanos de los participantes.

M3.11. **Salomone, G. Z. y Michel Fariña, J. J.** “El experimento de Stanley Milgram: Cuestiones éticas y metodológicas”.

En su ensayo *El experimento de Stanley Milgram: cuestiones éticas y metodológicas*, Gabriela Z. Salomone y Juan Jorge Michel Fariña analizan la evolución metodológica y los dilemas éticos que rodean al célebre estudio sobre obediencia a la autoridad realizado por Stanley Milgram en la Universidad de Yale en 1963. El diseño original buscaba medir la influencia del castigo en el aprendizaje: un sujeto ingenuo (asignado al rol de «maestro» mediante un falso sorteo) debía administrar descargas eléctricas crecientes (de 15 a 450 voltios) a un actor cómplice («alumno») situado en una habitación contigua cada vez que este cometía un error en una prueba de memoria. Aunque las descargas eran simuladas, el alumno emitía gritos de dolor, alegaba afecciones cardíacas y pedía ser liberado. La conclusión más perturbadora del experimento fue que el 65% de los participantes obedeció las órdenes del investigador hasta presionar el interruptor de rango máximo de 450 voltios, evidenciando la facilidad con la que personas ordinarias ceden ante una autoridad legítima.

Salomone y Michel Fariña examinan cómo este estudio desencadenó un debate ético que transformó los criterios de investigación en ciencias sociales, especialmente en lo referente al uso de *consignas engañosas*. En metodología de la investigación, el engaño consiste en ocultar la verdadera hipótesis o naturaleza del estudio cuando revelarla inutilizaría el procedimiento. En la actualidad, la Norma 8.07 del Código de Ética de la American Psychological Association (APA) regula el engaño mediante tres requisitos estrictos: (a) debe estar justificado por un valor científico o educativo significativo sin alternativas no engañosas disponibles; (b) no se debe engañar sobre aspectos que puedan causar dolor físico o severo malestar emocional; y (c) se debe realizar un *debriefing* (interrogatorio o sesión explicativa posterior) tan pronto como sea posible, revelando la verdadera naturaleza del experimento y permitiendo a los participantes retirar sus datos. Dado que el diseño de Milgram sometía a los sujetos a un estrés psicológico extremo y carecía de una revelación inmediata, una réplica exacta resulta éticamente irrealizable bajo los códigos modernos.

Para salvar estas prohibiciones deontológicas sin perder la fuerza investigativa del modelo, el investigador Jerry Burger diseñó en 2009 una réplica que incorporó la denominada «solución de los 150 voltios». Al reanalizar minuciosamente los datos originales de Milgram, Burger descubrió que la descarga de 150 voltios funcionaba como un «punto de no retorno»: el 79% de los sujetos que decidían continuar tras aplicar 150 voltios llegaban inevitablemente hasta el nivel máximo de 450 voltios. Basándose en este hallazgo, Burger detuvo su experimento inmediatamente

después de que el participante administraba la descarga de 150 voltios, logrando medir la decisión de obedecer sin someter al sujeto a las cuotas sucesivas de estrés. Asimismo, Burger implementó severos resguardos éticos: un doble proceso de selección para excluir candidatos vulnerables, la reducción de la descarga de prueba de 45 a 15 voltios, la presencia supervisora de un psicólogo clínico, la reunión inmediata con el alumno sano tras la prueba y la entrega de un consentimiento informado escrito donde se garantizaba que podían retirarse en cualquier momento conservando la retribución de 50 dólares.

La inclusión de un consentimiento informado que explicita la libertad de retiro pone de manifiesto una profunda tensión teórica entre la autonomía escrita y la autoridad verbal. En el diseño de Milgram, ante cualquier duda del participante, el experimentador administraba cuatro instrucciones verbales progresivamente coercitivas («Continúe por favor», «El experimento requiere que usted continúe», «Es absolutamente esencial que usted continúe» y «No tiene opción, tiene que continuar»). En la réplica de Burger, detener la prueba a los 150 voltios impidió verificar si los sujetos apelarían a su consentimiento escrito para desobedecer las órdenes verbales del investigador. Sin embargo, esta tensión quedó evidenciada en la recreación realizada en 2006 por el mentalista británico Derren Brown para la televisión. Eximido de comités de ética científica por ampararse en la libertad de prensa, Brown ofreció la garantía verbal de que los participantes podían retirarse y conservar el dinero; aun así, más del 50% continuó aplicando descargas hasta los rangos más altos sin ejercer el derecho que los asistía.

Finalmente, Salomone y Michel Fariña contrastan el rigor deontológico exigido en el ámbito académico con el pragmatismo mediático de las adaptaciones televisivas y cinematográficas, como la película *¿... como Ícaro* de Henri Verneuil (1979) o el programa de Derren Brown. Los autores destacan que, mientras Milgram identificó a las figuras de autoridad tradicionales (policías, científicos, jueces) como las fuentes primarias de la obediencia, las réplicas contemporáneas de la televisión exponen la emergencia de un nuevo factor de alienación subjetiva. Cuando los participantes son informados a posteriori de que su conducta será emitida en televisión y aceptan la exposición a cambio de una retribución económica o figuración pública, demuestran que el magnetismo mediático-mercantil funciona hoy como un dispositivo de sumisión tan eficaz como la autoridad científica tradicional. Salomone y Michel Fariña concluyen que la enseñanza del experimento de Milgram debe integrar de manera inseparable los aspectos metodológicos y los resguardos éticos, demostrando que estos últimos no son trabas burocráticas externas, sino componentes conceptuales indispensables para comprender la agencia humana y las posibilidades de resistencia del sujeto.

M3.04. FePRA. “Código de Ética de la República Argentina”.

El *Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina* (FePRA), aprobado originalmente en 1999 y reformado en 2013, constituye el marco deontológico unificado que rige el ejercicio de la psicología en todo el territorio nacional. Concibiendo la salud mental como un derecho humano fundamental y alineándose con la defensa del sistema democrático y la justicia social, el Código se presenta como un documento de armonización para las distintas jurisdicciones provinciales. Su arquitectura formal se organiza a partir de una clara distinción entre el Preámbulo y la **Declaración de Principios** (Principio A: Respeto por los derechos y la dignidad de las personas; Principio B: Competencia; Principio C: Compromiso profesional y científico; Principio D: Integridad; y Principio E: Responsabilidad social), los cuales establecen objetivos deseables e inspiradores que representan el espíritu de la disciplina, y las **Normas Deontológicas**, que fijan reglas de conducta profesional de cumplimiento obligatorio. En el proceso de toma de decisiones, el psicólogo debe guiarse por la norma ética más elevada frente a eventuales contradicciones con leyes u ordenamientos institucionales, asumiendo la decisión final bajo su exclusiva responsabilidad individual.

La Declaración de Principios —basada en los consensos éticos del Mercosur— exige hacer propios los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, manteniendo una formación científica actualizada, una conducta proba y un compromiso activo con el bienestar comunitario. Esta fundamentación se concreta en la Sección 1 de las Normas Deontológicas mediante la regulación del *consentimiento informado*. Sustentado en el principio de autonomía, el consentimiento no es concebido como un trámite administrativo estático, sino como un proceso dinámico de construcción y revisión continua a lo largo de la relación profesional. Para ser válido, requiere capacidad legal o psíquica, libertad de decisión e información clara sobre el propósito de la práctica, confidencialidad, riesgos, beneficios, alternativas y el derecho a retractarse en cualquier momento. En personas imposibilitadas de consentir por razones legales o emocionales, el consentimiento debe obtenerse de sus representantes legales, procurando simultáneamente el acuerdo o asentimiento del consultante y reservándose la intervención sin consentimiento únicamente para situaciones de catástrofe, urgencia o riesgo inminente.

La Sección 2 regula el *secreto profesional* como un deber primordial destinado a resguardar la intimidad, seguridad y dignidad de los consultantes, sus familias y comunidades. Esta obligación de confidencialidad constituye la esencia misma de la práctica, subsiste indefinidamente tras la finalización del servicio y no se

extingue con la muerte del paciente, extendiéndose de igual modo a equipos de trabajo interdisciplinarios y sistemas de archivo informático o físico. Sin embargo, la Norma 2.8 contempla situaciones excepcionales donde la revelación de información confidencial no constituye una falta ética. Estas excepciones se limitan estrictamente a: (1) proteger al propio consultante o a terceros de un daño presumible derivado del estado de salud mental de aquel; (2) evitar la comisión de un delito o prevenir sus daños; (3) ejercer la legítima defensa ante denuncias formuladas por el consultante en ámbitos policiales, judiciales o profesionales; y (4) cumplir con la solicitud o autorización explícita y por escrito del propio consultante. En todos los casos, la información revelada debe ser la estrictamente indispensable y ser transmitida a personas capaces de preservar la reserva. La Sección 3 ordena la responsabilidad en las relaciones profesionales con consultantes, colegas y la comunidad. Reconociendo la *posición asimétrica* que ocupa el psicólogo en la relación terapéutica, la norma prohíbe utilizar dicho lugar para satisfacer intereses personales, recibir gratificaciones distintas a los honorarios o entablar vínculos previos/simultáneos (comerciales, laborales o afectivos) que contaminen el objetivo clínico. De forma taxativa, la Norma 3.1.6 establece la prohibición de involucrarse sexualmente con los consultantes, imponiendo la obligación de derivar el caso si surgiera un vínculo afectivo que obstaculizase la meta profesional. Respecto a los colegas, el Código exige respeto mutuo, prohíbe la competencia desleal, la difamación y la pretensión de desplazar a un par fuera de los concursos legales. Ante la comunidad, el profesional debe actuar con idoneidad, absteniéndose de aplicar técnicas no avaladas científicamente, denunciando el *curanderismo* y el ejercicio ilegal, y rechazando categóricamente cualquier participación activa o pasiva en torturas o actos que atenten contra los Derechos Humanos. Finalmente, las Secciones 4, 5 y 6 estructuran el ejercicio de la investigación, la docencia y las declaraciones públicas. La investigación psicológica queda subordinada a la obtención de resultados humanitariamente benéficos, exigiendo el consentimiento informado de los participantes, la protección de poblaciones vulnerables y la restricción de técnicas de engaño solo cuando no existan alternativas e implique un valor científico comprobado. En la docencia, se exige garantizar el nivel académico, enseñar el uso de técnicas solo a profesionales o estudiantes habilitados y anonimizar rigurosamente los datos de identificación al utilizar casos clínicos como material ilustrativo. En la publicidad y divulgación masiva, los psicólogos deben actuar con rigor científico y mesura, prohibiéndose la publicidad de honorarios, la promoción de técnicas no validadas o el uso del prestigio profesional para recomendar productos comerciales. A través de este cuerpo deontológico integral, la FePRA asegura que la práctica de la psicología en Argentina responda a criterios unificados de competencia técnica, veracidad, responsabilidad social y resguardo irrestricto de la dignidad humana.

M4.01. Arendt, A. "La responsabilidad personal bajo una dictadura".

El ensayo de Hannah Arendt aborda las implicancias éticas de la responsabilidad personal en el contexto de regímenes totalitarios, tomando como punto de partida la encendida controversia desatada por su obra *Eichmann en Jerusalén*. Arendt advierte la presencia de un extendido temor contemporáneo a emitir juicios morales, el cual suele ampararse en una falsa modestia condensada en la pregunta "¿quién soy yo para juzgar?". Para la autora, esta reticencia esconde una falta de autoconfianza y el deseo de eludir la propia responsabilidad, diluyendo los actos individuales en tendencias históricas abstractas o en el supuesto de que nadie es un agente libre. Frente a esta confusión, resulta indispensable trazar una distinción tajante entre la responsabilidad política y la responsabilidad personal o moral. La responsabilidad política es de carácter colectivo e histórico; cada generación, por el solo hecho de nacer en una comunidad política, asume el legado, las deudas y los actos cometidos por sus antecesores. Por el contrario, la responsabilidad personal y moral es estrictamente individual e intransferible, atañendo de forma exclusiva a los actos u omisiones realizados por personas de carne y hueso con nombre y apellido.

A partir de esta diferenciación, la autora refuta la falacia de la culpa colectiva. Sostener que toda una nación, una religión o la raza humana en su conjunto es culpable por los crímenes del nazismo constituye un mecanismo de exculpación sumamente eficaz, pues donde todos son culpables, en la práctica nadie lo es. En términos morales y jurídicos, solo se puede ser culpable o inocente por actos concretos que un individuo haya ejecutado. En esta misma línea, Arendt deconstruye la denominada "teoría del engranaje", utilizada habitualmente por la defensa de los criminales nazis. Aunque desde la ciencia política la burocracia totalitaria funciona mediante individuos reducidos a piezas o dientes intercambiables de una gigantesca maquinaria, en un tribunal de justicia esa abstracción carece de validez. El juzgamiento no procesa a un sistema ni a una corriente histórica, sino a un ser humano; por lo tanto, la pregunta que la ética y la justicia dirigen al acusado es por qué eligió convertirse o continuar siendo una pieza de un engranaje criminal.

Del mismo modo, el texto desarticula la doctrina de las órdenes superiores y la falacia del "mal menor". En los regímenes totalitarios, el argumento de optar por el mal menor fue utilizado conscientemente por la maquinaria del terror para condicionar gradualmente a la población y a los funcionarios, haciéndoles aceptar pequeñas injusticias sucesivas hasta desembocar en el exterminio masivo. Asimismo, Arendt realiza un desmontaje del concepto de "obediencia" en el campo político y moral. Los adultos no obedecen como los niños ni son coaccionados

como los esclavos; en la esfera pública de los adultos, la palabra obediencia es un eufemismo que significa en realidad apoyo y consentimiento. Quien afirma haber obedecido las órdenes de un régimen totalitario está admitiendo que prestó su apoyo voluntario a la empresa criminal de ese gobierno.

Finalmente, la autora interroga cómo fue posible que un pequeño grupo de individuos se negara a colaborar con el régimen nazi sin haber sido héroes o sabios. Los no-participantes no fueron aquellos que se aferraban rígidamente a las normas y pautas morales tradicionales de la sociedad respetable, pues la experiencia demostró que esas pautas pueden cambiar de la noche a la mañana y ser reemplazadas por un nuevo orden legal cuya regla central sea el mandamiento "matarás". Quienes no colaboraron fueron aquellos cuyo criterio no funcionó de manera automática mediante reglas aprendidas, sino que ejercieron la capacidad de pensar y juzgar por sí mismos. El pensamiento es definido por Arendt como ese diálogo silencioso entre "el yo y yo mismo". Los no-participantes decidieron retirarse de la vida pública y no apoyar al régimen porque se preguntaron si podrían seguir viviendo en paz consigo mismos tras cometer un crimen, eligiendo incluso la muerte antes que verse obligados a convivir el resto de sus días con un asesino: ellos mismos.

M4.04. Calligaris, C. “La seducción totalitaria”.

En su ensayo *La seducción totalitaria*, el psicoanalista Contardo Calligaris examina los fundamentos subjetivos del totalitarismo, rechazando las explicaciones convencionales que lo atribuyen a un fenómeno político externo, a la pura alienación tecnológica o a un sadismo individual. Analizando las figuras de Albert Speer —arquitecto de Hitler y ministro de armamentos del Tercer Reich— y de Rudolf Hoess —comandante del campo de exterminio de Auschwitz—, Calligaris cuestiona las tesis filosóficas que culpan al desarrollo de la técnica en sí mismo de la barbarie moderna. En su lugar, el autor sostiene que el totalitarismo resulta tan cautivador porque apela a una tendencia inercial profunda de la subjetividad humana: la *pasión de la instrumentalización*, entendida como el deseo del sujeto neurótico de desembarazarse de su propio sufrimiento e incertidumbre reduciéndose a la condición de un mero instrumento operativo al servicio de un sistema.

Para explicar el atractivo de esta renuncia subjetiva, Calligaris recurre a la estructura de la neurosis. En la teoría psicoanalítica, la neurosis se caracteriza por el hecho de que el saber sobre el deseo está siempre «supuesto» en la figura paterna (*saber paterno supuesto*). Dado que este saber nunca está completamente escrito o accesible, el sujeto neurótico habita en una incertidumbre constitucional respecto de lo que verdaderamente quiere, corriendo detrás de una deuda simbólica impagable y experimentando una insatisfacción constante. Frente a esta angustiante duda existencial, el sujeto encuentra un atajo tentador: transformar el saber supuesto en un *saber sabido y compartido*, es decir, adoptar un sistema de certezas absolutas donde el sentido y las tareas están plenamente prescriptos. Al ofrecerse como un instrumento ejecutor de este saber compartido, el sujeto construye un «semblante de certeza» que le permite salir del sufrimiento neurótico banal y acceder a una forma de goce (*goce*) no insatisfactorio, operando una verdadera estructura perversa en el plano de la acción social.

Esta salida perversa se manifiesta en lo que Calligaris denomina el *goce del funcionario ejemplar*. Los crímenes cometidos por los burocratas totalitarios no respondían primordialmente a un impulso sádico o a un odio apasionado, sino a la satisfacción de ejecutar una función administrativa con absoluta perfección técnica. En sus memorias, Rudolf Hoess se defendió de las acusaciones afirmando que su único goce consistía en ser un «funcionario modélico». Del mismo modo, la construcción de una estación de tren falsa en el campo de Treblinka —con carteles pintados, guardarios ficticios y un reloj de madera detenido a la misma hora— no obedecía únicamente a razones logísticas para evitar rebeliones, sino al deseo obsesivo de garantizar que el sistema funcionara impecablemente, reduciendo a

las víctimas a puros objetos operativos. El sistema totalitario es inherentemente expansivo porque la existencia de individuos que rechazan funcionar como instrumentos cuestiona la validez del «saber sabido», exigiendo su supresión para mantener la consistencia del orden.

Calligaris afirma que la pasión de la instrumentalización no es exclusiva de los regímenes fascistas, sino que constituye la inercia natural de los lazos sociales y asociativos cotidianos. Cualquier institución o grupo humano posee una tendencia totalitaria que busca gestionar plenamente la vida cotidiana y reducir al sujeto a su función instrumental. Aplicando esta tesis a los procesos políticos latinoamericanos, el autor analiza el principio de la *obediencia debida* invocado por militares y ejecutores de la represión. Lejos de constituir una excusa o un atenuante jurídico, la obediencia debida representa un *agravante ético y jurídico*: demuestra que el sujeto estuvo dispuesto a pagar cualquier precio humano —incluyendo la tortura y el asesinato masivo— únicamente para disfrutar del confort subjetivo de ser un instrumento eficaz y liberarse de la angustia de la decisión personal.

Finalmente, Calligaris conceptualiza una mutación histórica en los ideales sociales y sus consecuencias clínicas. Apoyándose en la definición marxista del capitalismo como una acumulación de mercancías, el autor señala el pasaje de las sociedades del siglo XIX, organizadas alrededor de ideales del *Ser* (bravura, honor, coraje, los cuales mantenían al sujeto en el terreno de la incertidumbre), a las sociedades contemporáneas organizadas alrededor de ideales del *Tener* (acumulación de objetos y bienes cuantificables). En la cultura del *Tener*, el ideal puede ser medido y sabido (*saber sabido*), lo que promueve la transformación del síntoma social neurótico en un *síntoma social perverso*. Fenómenos contemporáneos como la adicción a las drogas reflejan esta dinámica, ofreciendo una relación directa con un objeto plenamente designado que promete un goce sin falta. Calligaris concluye que los sujetos contemporáneos enfrentan un horizonte totalitario sin necesidad de dictaduras formales, donde la promesa de satisfacción mediante la alineación instrumental desafía al psicoanálisis a sostenerse como una trinchera ética en defensa del deseo y la incertidumbre del sujeto.

M4.01. Lewkowicz, I. "Catástrofe, experiencia de una nominación".

En su texto *Catástrofe: experiencia de una nominación*, Ignacio Lewkowicz realiza una profunda intervención filosófica e historiográfica sobre el término «catástrofe», rechazando su uso común como un mero intensificador cuantitativo de la crisis. En su lugar, Lewkowicz conceptualiza la catástrofe como una *palabra-umbral* —una categoría que inicia un pasaje desde la dimensión del conocimiento abstracto hacia la dimensión de la experiencia inmanente, incluyendo la catástrofe de los propios conceptos utilizados para comprenderla—. Para precisar su especificidad, el autor construye una rigurosa tipología comparando cómo tres fenómenos distintos se relacionan con un *impasse* o quiebre en una estructura previa. El *traumatismo* describe la suspensión temporal de una lógica provocada por un estímulo excesivo; como una inundación que finalmente retrocede, la estructura sólida preexistente asimila progresivamente el exceso y restaura su funcionamiento. El *acontecimiento* ocurre cuando irrumpe un elemento cualitativo e inasimilable —como la «toma de la palabra» en mayo del 68— que desquicia la estructura e inicia la invención de esquemas inéditos y la afirmación de voces inauditas. En franco contraste, la *catástrofe* constituye una resta pura de ser y un desmantelamiento permanente de las marcas simbólicas sin armar otra lógica sólida equivalente: aquí «la inundación llega para quedarse», desvaneciendo el principio estructural mismo.

Lewkowicz conecta esta conceptualización con la transformación histórica contemporánea: la destitución del Estado-Nación como la práctica dominante productora de realidad. Durante la era estatal, la existencia humana era inherentemente estructural, siendo el Estado el articulador simbólico que proveía sentido a la totalidad de las situaciones. En la era de la fluidez neoliberal, el colapso del Estado no conduce a una transición ordenada hacia una nueva totalidad sólida ($A \rightarrow B$), sino a un devenir caótico sin reglas ($A \rightarrow C$). De este modo, la noción tradicional de «crisis» sufre una mutación radical: la crisis deja de ser un *impasse* momentáneo o una fase de pasaje hacia un nuevo orden, para convertirse en el funcionamiento efectivo y permanente de la realidad, es decir, en un «modo de ser». En este medio fluido, el Estado deviene un aparato técnico-administrativo incapaz de ordenar la heterogeneidad, mientras que la dinámica del mercado —encarnada en la potencia omnívora del capital financiero— opera no mediante la articulación simbólica, sino a través de conexiones y desconexiones reales que prosperan en la alteración constante.

Frente a esta realidad post-estatal, Lewkowicz establece una distinción crucial entre dos posiciones para leer y habitar la catástrofe: pensar desde *lo que queda* frente a pensar desde *lo que hay*. Pensar desde «lo que queda» es una

postura melancólica que evalúa el presente únicamente desde la añoranza de la solidez perdida, concibiendo la catástrofe como puro arrasamiento, ruina y desvinculación. Por el contrario, pensar desde «lo que hay» constituye una posición inmanente y operatoria que realiza un inventario de las condiciones fluidas presentes para actuar desde ellas. Mirada desde sí misma, la catástrofe modifica su determinación interna: deja de definirse como la ruina de las marcas del pasado y se rearticula como el primado de la transformación sobre la permanencia, convirtiendo la contingencia en la condición primaria de la experiencia.

En un medio fluido, la garantía estructural de estabilidad desaparece, convirtiendo a la contingencia en el rasgo dominante. Lewkowicz utiliza la analogía de la física de los fluidos para ilustrar que dos puntos o individuos permanecen juntos únicamente si realizan el trabajo pertinente para seguir juntos, pues la tendencia natural del medio fluido es la separación, la dispersión y el choque fortuito (*choque*). Sin embargo, la fluidez contiene también una virtud dinámica: si bien el medio separa puntos, simultáneamente acerca otros. Es allí donde se abre la posibilidad de la subjetividad post-catastrófica. Lejos de celebrar un azar vacío o resignarse a la dispersión trágica, la subjetividad emerge a través de un *trabajo subjetivo* capaz de intervenir sobre la casualidad del choque para sostenerlo y producir un verdadero *encuentro*.

Finalmente, Lewkowicz formaliza la dimensión socioeconómica de la catástrofe radicalizando la premisa psicoanalítica de Jacques Lacan de que «no hay relación sexual». En la era del capital financiero, la catástrofe desplaza el acento hacia la esfera social: *no hay relación social*. El capital financiero impone un régimen de disyunción universal donde los flujos del mercado conectan puntos aislados sin generar lazo simbólico, volatilizando los vínculos sociales en pura dispersión. Cada agente de mercado se convierte en un punto catastróficaamente aislado, desvinculado de cualquier anclaje colectivo estable. Lewkowicz concluye que la catástrofe, habitada desde sus propias estipulaciones, deja de ser una ruina externa para convertirse en un nuevo punto de partida ontológico: un umbral donde el pensamiento ya no puede apoyarse en las garantías del Estado, sino que debe construir consistencia precaria e inmanente mediante la producción subjetiva de encuentros.

M4.02. Gutiérrez, C. "Eichmann y la responsabilidad".

En su ensayo *Eichmann y la responsabilidad*, Carlos E. F. Gutiérrez realiza un análisis crítico del juicio celebrado en Jerusalén en 1961 contra Adolf Eichmann, contrastándolo con el proceso de Núremberg de 1945. Mientras que Núremberg juzgó a los altos jerarcas y planificadores del Tercer Reich, el tribunal de Jerusalén sentó en el banquillo a un oficial de segunda línea responsable de la logística organizativa del Holocausto: el censo de las poblaciones judías, su guetificación y la coordinación de los transportes ferroviarios hacia los campos de exterminio. Gutiérrez señala que el proceso de Jerusalén estuvo atravesado por una fuerte manipulación política que convirtió la instancia judicial en un espectáculo de Estado destinado a consolidar la identidad nacional israelí, lo cual oscureció la verdadera naturaleza de la responsabilidad del acusado.

Gutiérrez pone al descubierto una doble falacia presente en el juicio. Por un lado, la acusación presentó a Eichmann como una «fiera en la jungla», retratándolo como un monstruo movido por el odio sádico y la pasión criminal. Sin embargo, los documentos e interrogatorios revelaron lo contrario: Eichmann era un burócrata de oficina metódico y eficiente, cuyas armas eran la estilográfica y el formulario administrativo, encarnando la «banalidad del mal» conceptualizada por Hannah Arendt. Por otro lado, la defensa de Eichmann se basó enteramente en la coartada de la *obediencia debida*, argumentando que él era un simple «agente de transmisión» obligado a cumplir órdenes superiores bajo su juramento de lealtad al Führer. Al superponer el lenguaje administrativo al proceso de exterminio, Eichmann se declaraba enajenado de la realidad del asesinato físico, sintiéndose internamente «liberado de toda responsabilidad».

El autor refuta los intentos de desimplicación subjetiva de Eichmann, desmontando en particular su argumento contrafáctico de que «si no lo hubiera hecho él, otro lo habría hecho en su lugar». Gutiérrez aclara que a Eichmann no se le juzgaba por el resultado global de la Segunda Guerra Mundial, sino por haber decidido prestarse él mismo como engranaje indispensable de la maquinaria de muerte. Asimismo, Gutiérrez analiza la paradoja ocurrida hacia el final de la guerra, cuando Eichmann desobedeció las órdenes de Himmler de detener las deportaciones para continuar enviando trenes a los campos. Lejos de demostrar una voluntad o sadismo independiente, esta desobediencia fue el acto supremo de sumisión, pues para la lógica de Eichmann la palabra del Führer constituía la única ley absoluta por encima de cualquier otro superior jerárquico.

La tesis central del ensayo radica en señalar la incapacidad del derecho positivo para conceptualizar el *crimen burocrático*. Debido a que el sistema jurídico tradicional exige demostrar intención deliberada, malicia personal o conciencia de

daño (*imputabilidad*) para aplicar una pena, la corte no podía condenar a Eichmann basándose únicamente en su obediencia a órdenes de Estado. Para eludir este límite, la fiscalía recurrió a una pirueta retórica: inventó una «identificación total con las órdenes» para atribuirle una «voluntad encarnizada de hacer el mal». Gutiérrez critica este malabarismo psicologista, sosteniendo que el derecho perdió de vista lo esencial: el verdadero crimen fue la obediencia misma. Lo que debía habersele reprochado a Eichmann era su decisión de someterse y ofrecerse como instrumento eficiente de una ingeniería burocrática de exterminio.

Finalmente, Gutiérrez contrapone la imputabilidad jurídica con la *responsabilidad subjetiva*. Mientras el fuero legal busca la culpa en la intención conciente del individuo, la ética psicoanalítica interpela la decisión del sujeto de someter su juicio y prestarse a un aparato de destrucción. Para ilustrar los límites del discurso jurídico, el autor evoca el final de *El proceso* de Franz Kafka, donde Joseph K. es ejecutado «como un perro» y siente que «la vergüenza le sobrevivirá». Gutiérrez concluye que, así como la vergüenza sobrevive al juicio en la novela kafkiana, la verdadera responsabilidad ética excede las categorías del derecho positivo, demostrando que la sumisión burocrática fue el crimen insospechado que la justicia no alcanzó a nombrar.

M4.09. Ulloa, F. “Ética del analista ante lo siniestro”.

En su ensayo *La ética del analista ante lo siniestro* (1984), Fernando Ulloa formula un riguroso manifiesto sobre la posición del psicoanalista frente a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar en Argentina. Ulloa plantea que el psicoanálisis no es una práctica técnica pura ni un conjunto de procedimientos neutrales, sino una propuesta intrínsecamente ética fundada en el desocultamiento de la verdad. El propósito central del psicoanálisis es revelar aquella verdad que, permaneciendo encubierta para el propio sujeto, se manifiesta en forma de síntoma —entendido como una solución de compromiso negociada ante el conflicto—. Frente a la violencia de Estado, el profesional no puede eludir esta responsabilidad: o su práctica hace justicia promoviendo la verdad que alivia el padecimiento, o se convierte, a sabihondas o no, en cómplice de la opresión. La condición humana es de naturaleza trágica, atravesada por la tensión entre el cuidado y la agresión, el amor y el odio; esta dicotomía tiene solo dos salidas posibles: la vía ética, donde la producción de verdad cimenta la justicia, o el callejón ciego del ocultamiento, donde el síntoma sofocado resurge en forma de alienación, perversión violenta o delirio psicótico.

Para conceptualizar la especificidad del terrorismo de Estado, Ulloa recupera el concepto freudiano de *lo siniestro* (*Das Unheimliche*), definido como aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo antiguo y familiar (*heimlich*). Etimológicamente, la adición del prefijo de negación transforma lo familiar en algo oculto, secreto y clandestino. Lo siniestro representa la convergencia paradójica entre lo secreto y lo cotidiano, configurando un fenómeno que, siendo familiar, resulta al mismo tiempo profundamente desorientador e inquietante. Ulloa ilustra esta dinámica mediante el «secreto de familia» en la clínica privada, citando el caso de las niñas apropiadas durante la dictadura que fueron secuestradas y criadas por los propios ejecutores del secuestro. Al ser un secreto no dicho, la verdad reprimida no puede articularse en un relato mediante la palabra, pasando a infiltrar y pervertir de forma maligna todas las estructuras psíquicas y vínculos de la víctima, amenazándola con la desintegración cognitiva o psíquica.

El autor traslada este análisis del ámbito privado a la comunidad entera, demostrando que el terrorismo de Estado funcionó como una metodología planificada de desaparición, silencio y tormento. Los ejecutores directos del horror, amparados en la impunidad y en el ocultamiento, encarnaron la figura misma de lo siniestro. Impulsados por un sadismo fascista, estos operadores necesitaban multiplicar constantemente el número de sus víctimas —una dinámica de envilecimiento que Ulloa compara con la necesidad de «alimentar a Drácula»— para adormecer su propio horror interno y paralizar a la sociedad. Por su parte, la

comunidad destinataria de la represión fue sometida a un «encapuchamiento de la evidencia», donde el pánico y la incertidumbre llevaron a grandes sectores sociales a adoptar mecanismos de ceguera defensiva y racionalizaciones cobardes — resumidas en frases emblemáticas como «en algo andaría» o «algo ha de saber»— que alimentaron la impunidad del verdugo y multiplicaron la angustia de los familiares de los desaparecidos.

Frente a la malignidad infiltrante de lo siniestro, Ulloa sostiene de forma categórica que el único antídoto eficaz es el *develamiento* o desocultamiento de aquello que lo promueve, acompañado del establecimiento de un nuevo orden de legalidad. La verdad opera como una incisión quirúrgica necesaria que drena y alivia el absceso de lo siniestro, permitiendo transformar el horror mudo en una narrativa simbolizable. Por este motivo, el autor rechaza de manera tajante el olvido social como valor pacificador. Promover el olvido no restaura la inocencia ni cura las heridas de una nación; al contrario, el olvido consagra la impunidad, reinstala la fuente oculta de lo siniestro y promueve la repetición histórica de los crímenes.

Ulloa concluye afirmando que todo profesional que se pretenda psicoanalista se halla interpelado por las miles de víctimas de la represión, las cuales no le piden explicaciones del pasado, sino un testimonio de verdad en el presente de su práctica. Un verdadero analista no puede ser cómplice de la costumbre, la delegación o las alianzas negadoras de la sociedad. Aunque el terapeuta no realice una militancia política directa, su ejercicio clínico diario debe hacer justicia en la medida en que la producción de verdad opere como un antídoto frente al ocultamiento estatal. Para Ulloa, hacer justicia no es un evento abstracto ni un mero fallo judicial, sino una práctica ética y cotidiana que se sostiene en la negativa inquebrantable a desmentir la verdad.

M4.06. Gutiérrez, C; Lewkowicz, I. "Memoria, Víctima y Sujeto".

En su ensayo *Memoria, Víctima y Sujeto*, Carlos E. F. Gutiérrez e Ignacio Lewkowicz deconstruyen las operaciones políticas, culturales y clínicas contemporáneas que sustituyen la categoría ética de *sujeto* —concebido como el agente activo del inconsciente y del deseo— por la figura pasiva y sacralizada de la *víctima*. Los autores identifican dos trampas especulares que anulan la potencia subjetiva del sufriente. La primera es la *culpabilización de la víctima*, una práctica voyerista que escudriña la conducta moral del afectado —como evaluar la vestimenta de una mujer agredida— para justificar el delito e impunizar al victimario. La segunda trampa, opuesta en espejo, es la *sacralización de la víctima*, la cual eleva al doliente a un estado de pureza e inocencia absolutas. Etimológicamente derivada del latín *victima* (el animal u ofrenda destinada al sacrificio divino), esta operación —ilustrada en la censura de los párrafos sexuales y agresivos del *Diario de Anna Frank* o en la sacralización religiosa del Holocausto— transforma a seres humanos complejos en mártires inmaculados, perpetuando una liturgia mortífera del sufrimiento que atrapa al individuo en su propio padecimiento.

Apoyándose en el filósofo Alain Badiou, Gutiérrez y Lewkowicz sostienen que reducir a una persona a la condición de víctima, cuerpo torturado u organismo moribundo asimila la condición humana a su pura subestructura biológica animal: la «bestia sufriente» (*ser-para-la-muerte*). Aunque verdugos y víctimas comparten la mortalidad biológica, la condición de víctima no otorga por sí misma un valor moral superior ni una virtud ética. Para ilustrar la diferencia irreductible entre la mera supervivencia animal y la dignidad humana, los autores citan un pasaje del diario del Gueto de Varsovia escrito por Adam Czerniakow: un hombre indigente y moribundo pide dinero al Consejo Judío no para comprar comida, sino para alquilar una habitación, declarando explícitamente que se niega a morir en la calle como un perro. Incluso en el límite abismal entre la vida y la muerte, este individuo afirma una dignidad que resiste ser reducida a la pura condición de animal desamparado.

El texto critica duramente a los psicoprofesionales, a quienes denomina *los técnicos de la víctima*. En la práctica clínica moderna, estos especialistas construyen su saber observando minuciosamente el trauma y transformando el *síntoma* singular del paciente —el cual porta una pregunta inconsciente e invita al sujeto a interrogarse por su deseo— en un *diagnóstico* o etiqueta nosográfica estandarizada. Categorizar a las personas bajo emblemas colectivos como «afectado por el terrorismo de Estado», «bulímico» o «adicto» borra las huellas de la subjetividad. Este discurso diagnóstico ofrece un refugio de contención que agrupa a los dolientes en colectivos de autoayuda, afianzando una identidad basada en el

padecimiento compartido y desresponsabilizando al individuo de su propia posición subjetiva.

Gutiérrez y Lewkowicz establecen una distinción fundamental entre la *memoria* pasiva y la *historización crítica* o rememoración, guiados por la teoría lacaniana y las reflexiones literarias de Jorge Luis Borges. La memoria mediática y estatal se obstina en la conservación incontestable de las marcas del trauma, convirtiendo a la víctima en un «rehén de la memoria» condenado a repetir indefinidamente su posición de objeto ofendido. Por el contrario, la historización crítica es una operación activa del pensamiento que interrumpe la fijación a las marcas del pasado. Historizar no significa olvidar el crimen —postura que los autores denuncian como una «política del olvido» orientada a la impunidad de los victimarios—, sino dialectizar las marcas heredadas para producir una posición subjetiva nueva que supere la identidad victimaria.

Finalmente, los autores contrastan las políticas de representación estatal (*políticas de representación estatal*) con una auténtica *política del sujeto*. La política estatal requiere un suministro constante de víctimas para legitimar sus aparatos institucionales de representación, atrapando a los ciudadanos en una dinámica de reclamo y mendicidad hacia el Estado (*discurso del amo*). En contraste, una política del sujeto es un acto de ruptura. Los autores ilustran este pasaje subjetivo a través del caso de Yehiel Di-Nur, un sobreviviente de Auschwitz que testificó en el juicio a Eichmann bajo el seudónimo alienante *Ka-Zetnik* y se desvaneció ante las cámaras del tribunal. Años más tarde, Di-Nur abandonó la escenografía espectacular del desmayo, recuperó su verdadero nombre y consagró su vida como ciudadano a luchar contra el peligro de las armas nucleares. Al despojarse del estigma del «planeta Auschwitz» y hablar en nombre propio como sujeto deseante, Di-Nur demostró que un individuo puede salir del teatro mortífero de la victimización, transformando las marcas del trauma en un compromiso activo con el presente.

M4.07. Michel Fariña, JJ y Gutiérrez, C. “Veinte años son nada”.

En su ensayo *Veinte años son nada*, Juan Jorge Michel Fariña y Carlos Gutiérrez reflexionan sobre las consecuencias clínicas, éticas y políticas del terrorismo de Estado, la memoria y la impunidad a dos décadas del golpe militar de 1976 en Argentina. Los autores inician su análisis examinando la precisión del lenguaje utilizado para nombrar las masacres históricas, recuperando la postura del cineasta Claude Lanzmann (director del documental *Shoah*), quien rechazó el uso del término «holocausto» para calificar el genocidio nazi. Mientras que *Shoah* significa en hebreo catástrofe, desastre o ruina, «holocausto» procede del griego *holókaustos* («sacrificio consumido totalmente por el fuego»). Aunque los historiadores evitan el sesgo religioso de la palabra holocausto, los autores señalan que describe con precisión la mecánica psíquica de los Estados concentracionarios: dispositivos totalitarios organizados bajo un ideal de pureza racial que operan como un gigantesco sacrificio masivo de cuerpos humanos en el altar de un «dios oscuro».

Para indagar la dimensión humana en estas condiciones extremas, el texto establece una distinción conceptual rigurosa entre la *responsabilidad subjetiva* y la *culpa yoica*. Derivada del latín *respondere* (dar una respuesta), la verdadera responsabilidad no consiste en un «hacerse cargo» consciente o voluntarista desde el yo; por el contrario, interpela al sujeto en relación con su deseo inconsciente, tal como Freud lo formuló en *La responsabilidad moral por el contenido de los sueños*. Cuando la responsabilidad subjetiva es eludida, aparece en el yo su sustituto imaginario: la culpa, manifestada en remordimientos, tormentos y pesadillas. Los autores ilustran esta dinámica a través del caso del represor Adolfo Scilingo, cuyas pesadillas recurrentes arrojando víctimas desde aviones representan el precio psicológico de una responsabilidad eludida. En Argentina, los dispositivos estatales de impunidad —los «tres tiempos de la exculpación» constituidos por la ley de Punto Final, la ley de Obediencia Debida y los indultos presidenciales— provocaron una lesión simbólica profunda en la sociedad. El texto deconstruye el concepto de «obediencia» (del latín *audire*, oír): el obediente se limita a oír y ejecutar un código sin hablar, mientras que del sujeto responsable se espera que escuche y hable.

El núcleo del ensayo aborda la naturaleza de la tortura y desarticula los juzgamientos moralistas vertidos sobre los sobrevivientes. Tomando la escenografía ideada por Eduardo Pavlovsky para la obra *El señor Galíndez* —donde la mesa de tortura es representada como una camilla metálica de autopsias—, los autores definen la tortura como la abolición absoluta de los límites simbólicos, del tiempo y del lenguaje, reduciendo al individuo a una inermidad radical (*inermidad*

radical) y al desmembramiento real del cuerpo. Bajo el imperio del dolor infinito, la palabra es suprimida y reemplazada por un código mudo (claves o direcciones exigidas por el victimario). Por consiguiente, Fariña y Gutiérrez afirman que en la tortura no existen dilemas éticos ni elecciones posibles. Calificar a los sobrevivientes desde clichés morales —enalteciendo como «héroes» a quienes callaron o estigmatizando como «traidores» o «colaboradores» a quienes hablaron— constituye un juicio espurio: bajo el tormento físico absoluto no hay un sujeto eligiendo, y exigir el martirio a una víctima significa infligirle una segunda violencia moralizante.

Asimismo, los autores deconstruyen la fascinación social por los sobrevivientes como supuestos portadores de un saber sagrado o inaccesible. La vivencia del traumatismo extremo no configura un cuerpo de conocimientos pedagógicos transmisibles, sino una *antimemoria*: un agujero inenarrable en lo real (*agujero en lo real*) que habita en la carne como una herida abierta, manifestada en insomnios, cicatrices e interrupciones espectrales. Como declaró un sobreviviente del Gueto de Varsovia en el film *Shoah*: «Si usted pudiera lamar mi corazón, moriría envenenado». El sobreviviente no posee un recuerdo pacificado susceptible de ser olvidado, sino una laceración cotidiana que resiste la clausura narrativa.

En conclusión, Fariña y Gutiérrez examinan la articulación entre la memoria, la justicia y el olvido genuino. Los autores critican severamente las consignas de reconciliación obligatoria o amnesia decretada por el Estado —como la postura del filósofo Víctor Massuh, quien afirmaba que «el olvido restaura la inocencia»—, calificándolas de *olvido canalla* destinado únicamente a consolidar la impunidad de los verdugos. Un olvido auténtico no puede ser un acto voluntario o decretado; para olvidar eficazmente es necesario saber primero lo que se olvida. La verdadera resolución de la memoria traumática no es una tarea meramente clínica, sino una operación cultural y jurídica colectiva. Esta reconstrucción exige establecer la verdad histórica (*verdad histórica*), juzgar y castigar los crímenes de Estado, rechazar la coartada de la obediencia debida e inscribir una legalidad insostenible que funcione como soporte ético del lazo social (*lazo social*).

M4.10. Viñar, M. “La transmisión del patrimonio mortífero: premisas éticas para la rehabilitación de afectados”.

En su ensayo *La transmisión de un patrimonio mortífero: premisas éticas para la rehabilitación de afectados* (1985), el psicoanalista Marcelo Viñar establece las coordenadas clínicas y éticas para el abordaje terapéutico de los sobrevivientes de la tortura y el terrorismo de Estado en América Latina. Viñar inicia su argumentación delimitando una distancia insoslayable entre la vivencia real del horror y el *relato* o narrativa sobre dicho horror. Llevar la destrucción física y la muerte violenta al espacio de la palabra no es una operación inocente: la palabra no guarda una relación de equivalencia directa con el exterminio, sino de exclusión. El autor advierte sobre la trampa clínica y política de deslizarse hacia una fascinación morbosa por el horror (*voyeurismo* o patetismo), donde el terapeuta o el testigo, bajo el ropaje de la denuncia o la búsqueda de justicia, expropia la voz de la víctima y reitera alucinatoriamente la escena sádica del sufrimiento. La responsabilidad ética exige dar un paso al costado para construir un *intervalo* (una distancia simbólica) entre el horror y la palabra, transformando el estremecimiento paralizante en una narrativa que posibilite la historización, el duelo y la construcción de un porvenir.

Viñar cuestiona severamente la aplicación de los modelos médicos y sanitaristas al campo de la subjetividad, rechazando la importación de conceptos como «rehabilitación» o «reparación» cuando se abordan los efectos de la violencia estatal. Reducir el trauma a una patología médica cuantificable simplifica la complejidad del dolor humano y busca normalizar lo que es de suyo incalculable. Citando a Leo Bleger, Viñar afirma categóricamente que «no hay psicoterapias especiales para torturados», pues estas personas ya padecieron suficientes «tratamientos especiales» en los centros clandestinos de detención y en los cuarteles. La clínica con sobrevivientes no puede regirse por manuales estandarizados, protocolos de salud pública o respuestas preconcebidas. En lugar de ofrecer ilusiones de curación completa o soluciones técnicas universales, el terapeuta debe partir de lo *imposible* como norte de su tarea, reconociendo que la destrucción causada por el terrorismo de Estado no se borra, sino que solo puede ser dolorosamente reapropiada de una manera simbólica y menos mortífera.

Un pilar central del planteo de Viñar es la crítica al *humanismo heroico* y a las clasificaciones sociales maniqueas. Confirmar a los pacientes en los roles prefijados de «héroes» o «mártires» constituye un error de distancia que obtura su singularidad, aprisionándolos en ideales que impiden el trabajo analítico. En la crudeza de la sala de torturas —donde el dolor físico es absoluto y el cuerpo es sometido a la vivisección y a la pérdida de sus bordes—, las fronteras entre la

resistencia y la claudicación se vuelven opacas y complejas. La función del analista, sostenida en el principio de neutralidad, debe abstenerse tanto de la frialdad distante como de la compasión militantista. El clínico no debe juzgar ni enaltecer al consultante por haber hablado o callado bajo el tormento; por el contrario, la terapia debe permitir que el sujeto reasuma su destino humano singular, abrazando su experiencia con lo que esta comporta de trágico, absurdo o contradictorio.

El texto aborda la problemática de la transmisión intergeneracional del trauma, introduciendo el concepto de *patrimonio mortífero*. El horror que no ha sido metabolizado ni significado simbólicamente por los sobrevivientes se transmite a las siguientes generaciones como un legado tóxico, un virus que insiste y perjudica a los eslabones más débiles de la cadena familiar. Si existe una prevención o profilaxis posible en este campo, Viñar la conceptualiza en los términos de la tragedia edípica —el drama de los Labdácidas—: interrumpir la repetición del horror para evitar que el espanto se reproduzca en cada nueva generación. Para impedir que el patrimonio mortífero se transmita como un mandato mudo, la experiencia traumática debe ser inscrita en una memoria histórica acompañada de la sanción social y jurídica del crimen, creando el espacio vacío necesario para que los hijos puedan habitar su propia historia.

Finalmente, Viñar define la tarea específica del analista como un ejercicio de «descifrar enigmas». Frente a la respuesta única de cada individuo ante la catástrofe social, el terapeuta debe explorar con el paciente los límites de su sufrimiento, de su palabra y de su silencio. La estrategia clínica exige distinguir cuándo el decir es una *confesión traumática y repetitiva* (que reitera el tormento sin elaborar) y cuándo se transforma en una *aventura simbólica de elaboración* (que produce un sentido nuevo). Asimismo, el clínico debe discernir cuándo el silencio funciona como un refugio respetable para lo intolerable y cuándo debe ser intervenido. Viñar concluye que al renunciar al panfleto ideológico y sostener una escucha atenta y sensible, el psicoanalista ayuda al sobreviviente a inscribir una memoria que calme la intrusión alucinatoria del pasado, permitiendo que el sujeto recupere su derecho a la vida, al placer y a la dignidad.

Los cuatro casos de la serie "PSI" ("In treatment"; "En Terapia").

1. Caso Renato. **Identidad de Género y Particularismo.**
2. Caso Laura. **Amor de Transferencia y Abstinencia.**
3. Caso Paula. **Muerte Digna** - "La vida en mis manos".
4. Caso Alberto. **Pornografía Infantil** - "¿Es la fantasía un delito?"

1. Caso Renato (Identidad de Género y Particularismo)

La Situación: Renato (quien realizó su transición de género de Renata a Renato) solicita ante un juzgado el cambio de su DNI debido a un vacío legal en la materia. La fiscal encargada de autorizar el trámite obstaculiza el proceso alegando que la solicitud es un "capricho", que el cambio de sexo es un "camuflaje" peligroso para la seguridad social y que las personas tienen derecho a saber "la verdad" biológica de cada uno. En su discurso, la fiscal se refiere constantemente a él como "Renata".

La Intervención y el Giro Clínico: En sus propias sesiones de análisis con Carlo Antonini, la fiscal se queja de la "pereza" que le da el caso. Carlo le pregunta por qué insiste en llamarlo con el nombre femenino y cómo la neurosis nos hace adoptar posiciones rígidas sobre temas generales debido a conflictos inconscientes que nos son invisibles. En ese punto, la fiscal revela un hecho doloroso que mantenía oculto por vergüenza: su padre las abandonó a ella y a su madre cuando tenía 12 años para casarse con otro hombre.

Articulación Ética:

La fiscal incurre en un particularismo bajo la pantalla moral de la "igualdad para todos". Al exigir que Renato "pague el precio de sus decisiones", en realidad desplaza inconscientemente el reclamo de justicia y castigo que le correspondía a su propio padre por haberla abandonado.

El punto de inflexión ocurre cuando la fiscal escucha su propio alegato de forma invertida. Al implicarse subjetivamente, puede asumir su responsabilidad subjetiva, abandonar su cruzada discriminatoria, llamar a Renato por su nombre por primera vez y dar curso favorable al DNI.

2. Caso Laura (Amor de Transferencia y Abstinencia)

La Situación: Laura es una paciente de la serie In Treatment que asiste a terapia con el analista Paul. En el transcurso de las sesiones, Laura le confiesa a su terapeuta que está profundamente enamorada de él.

El Desafío Clínico: Paul se enfrenta a las demandas afectivas y erotizadas de la paciente. Metapsicológicamente, este enamoramiento no es un hecho civil de la realidad externa, sino un fenómeno provocado de manera típica por el propio

dispositivo clínico y motorizado por la resistencia a medida que el tratamiento se aproxima al núcleo de los síntomas.

Articulación Ética:

Principio de Abstinencia: Paul tiene la obligación ética y técnica de no responder a las demandas amorosas ni ofrecer ningún tipo de satisfacción. Debe mantener la frustración de la paciente para que la necesidad y la añoranza sigan funcionando como motores del trabajo analítico. Corresponder al amor o sofocarlo de manera autoritaria arruinaría definitivamente la cura.

Principio de Neutralidad: Paul debe excluir sus propios valores morales, religiosos y contra transferenciales del dispositivo, evitando entrar en el juego intersubjetivo que la paciente intenta imponerle.

Si el terapeuta cede a la tentación de ofrecer una promesa de satisfacción afectiva o sexual, la función analítica desfallece por completo, incurriendo en una gravísima falla ética y un abuso del poder asimétrico de la transferencia.

3. Caso Paula (Muerte Digna - "La vida en mis manos")

La Situación: Una madre anciana padece de un cáncer terminal avanzado sin posibilidades de mejora y sobrevive únicamente conectada a soportes artificiales. Los hijos varones deciden desconectarla para evitar una prolongación cruel de su agonía, pero su hija Paula se opone rotundamente, sosteniendo de manera rígida que quitarle los tubos equivale a cometer un "asesinato". Carlo Antonini interviene como mediador en el conflicto.

La Intervención y el Giro Clínico: Carlo le propone a Paula conversar a solas. En esas sesiones, Paula relata que su madre siempre fue sumamente controladora y asfixiante con ella, exigiéndole sumisión mientras era permisiva con sus hermanos varones. Carlo interviene con una frase que trastoca su posición: "Ahora eres tú quien controla a tu mamá". Poco después, se produce una perturbadora escena donde Paula maquilla de forma grotesca, casi sádica, el rostro de su madre sedada.

Articulación Ética:

Paula descubre que su férrea defensa moral de mantener conectada a su madre bajo el ideal de "lo que una buena hija debe hacer" ocultaba una venganza inconsciente: el placer de ejercer de forma activa el control absoluto sobre el cuerpo de su madre, devolviéndole de manera invertida el control que sufrió pasivamente en su infancia.

Al implicarse subjetivamente, Paula abandona la lógica binaria moral de sus hermanos (mantener conectada vs. asesinar) y asume una decisión singular y

responsable sobre la muerte de su madre, autorizando la desconexión desde un auténtico trabajo de duelo.

Concepto lacaniano: El maquillaje grotesco funciona como la estética de la belleza que opera como un velo o última trinchera del sujeto frente a la angustia de la castración y la inminencia de la muerte.

4. Caso Alberto (Pornografía Infantil - "¿Es la fantasía un delito?")

La Situación: Alberto confiesa a su terapeuta Carlo que siente atracción sexual hacia los niños y, específicamente, hacia su propia hija de 7 años, pero aclara con desesperación que se siente culpable y que jamás ha llevado estas fantasías a la acción en la realidad material. Sin embargo, posee un pendrive con clips de pornografía infantil que son animaciones digitales personalizadas, es decir, donde no participaron niños de carne y hueso en la producción. Su vecino descubre el pendrive y comienza a extorsionarlo.

Articulación Ética y Jurídica:

Realidad Psíquica vs. Realidad Material: El derecho penal castiga las acciones u omisiones (Art. 19 de la Constitución Nacional: las acciones privadas que no dañen a terceros están exentas de los magistrados). El sujeto es jurídicamente responsable de sus actos (el abuso), pero no de sus pensamientos o fantasías reprimidas.

La Tensión del Material Digital: Aunque la tenencia de material pornográfico infantil que involucre niños reales es un delito que atenta contra su dignidad, el caso de Alberto plantea un dilema porque sus clips son digitales. No obstante, la sexualización de la infancia, aun sin víctimas físicas directas, trastoca la representación simbólica de la niñez en el orden público, constituyendo un serio problema ético.